华创证券 HUA CHUANG SECURITIES

创新药系列研究：ESMO 2026 LBA国产新药数据梳理

首席分析师 郑辰 执业编号：S0360520110002 邮箱：zhengchen@hcyjs.com

高级分析师 朱珂琛 执业编号：S0360524070007 邮箱：zhukechen@hcyjs.com

本报告由华创证券有限责任公司编制

卖的出价或询价。本报告所载信息均为个人观点，并不构成对所涉及证券的个人投资建议。

请仔细阅读PPT后部分的分析师声明及免责声明。

知识星球：前沿信息收

VX:FCCNN88

©2021华创 版权所有

2026 ESMO中国创新药LBA概览

- 2026 ESMO（欧洲肿瘤内科学会）于2026年10月23日-10月27日在西班牙马德里召开，中国创新药大放异彩：
- 此次12项主席LBA中，中国分子共有5项，占比42%
- 按照2026年10月19日更新的大会最终日程统计LBA为91项，其中30项来自中国新药。



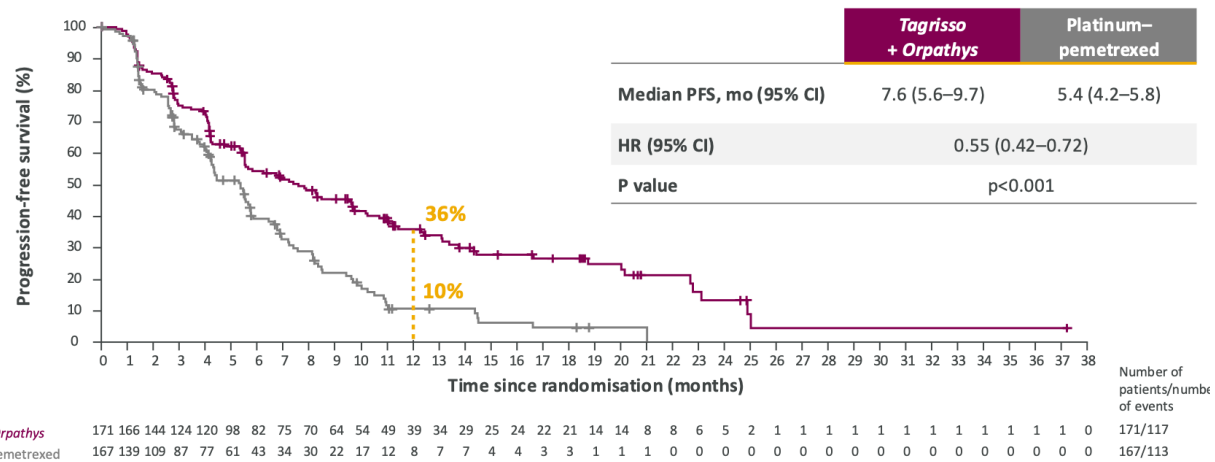
知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

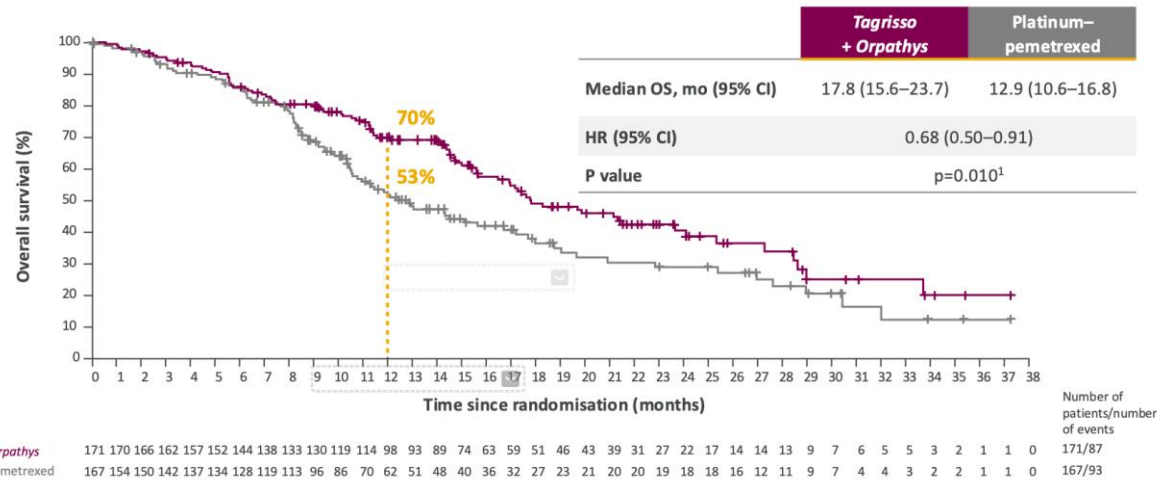
和黄医药/阿斯利康：SAFFRON研究实现PFS、OS双阳性

华创研究

- 在晚期EGFR突变NSCLC的一线治疗中，尽管奥希替尼疗效显著，但多数患者最终都会面临耐药，MET信号通路的失调是耐药的关键机制之一。在II期SAVANNA研究中，奥希替尼联合赛沃替尼在MET扩增患者中展现出持久且具临床意义的缓解。基于此，研究者开展全球III期SAFFRON研究，旨在奥希替尼联合赛沃替尼，对比培美曲塞联合铂类化疗，用于奥希替尼治疗后进展、伴MET过表达和/或扩增的EGFRm晚期NSCLC患者的疗效和安全性。
- SAFFRON研究纳入了338例既往接受过一线或二线奥希替尼治疗后疾病进展的伴有EGFR突变（Ex19del、L858R 和/或 T790M）的局部晚期或转移性NSCLC患者，且存在MET过表达和/或扩增（ ≥90%的肿瘤细胞呈**MET IHC 3+强度**，和/或FISH检测显示MET基因拷贝数≥10 ）。主要终点为BICR评估的PFS；次要和探索性终点包括OS、研究者评估的PFS及安全性。
- 疗效方面，经BICR评估，**赛沃替尼联合奥希替尼组患者的PFS较铂类化疗联合培美曲塞组显著延长（7.6 vs 5.4个月），疾病进展或死亡风险降低45%（HR=0.55，P<0.001）**。此外，赛沃替尼联合奥希替尼组患者的OS较铂类化疗联合培美曲塞组显著延长（17.8 vs 12.9个月），死亡风险降低32%（HR=0.68，P=0.010）。两组经BICR评估的DOR分别为9.7个月和5.7个月。
- 安全性方面，赛沃联合奥希治疗组常见治疗期间出现的TEAE包括外周水肿、贫血和腹泻，两组≥3级TEAE发生率分别为64%和63%；≥3级TRAE分别为40%和52%，因治疗相关不良事件停用任一研究药物的比例分别为12%和6%。总体安全性与既往已知安全性特征一致。

SAFFRON研究OS和PFS数据





数据来源：阿斯利康 ESMO 2026 演示材料

证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210

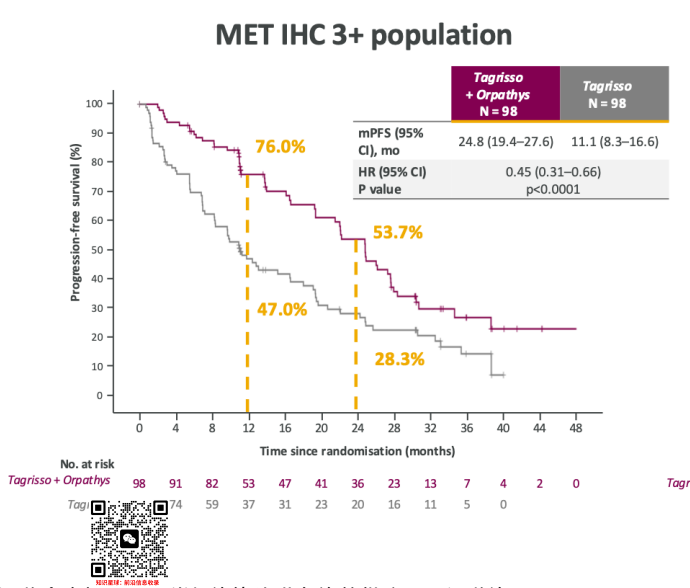
知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

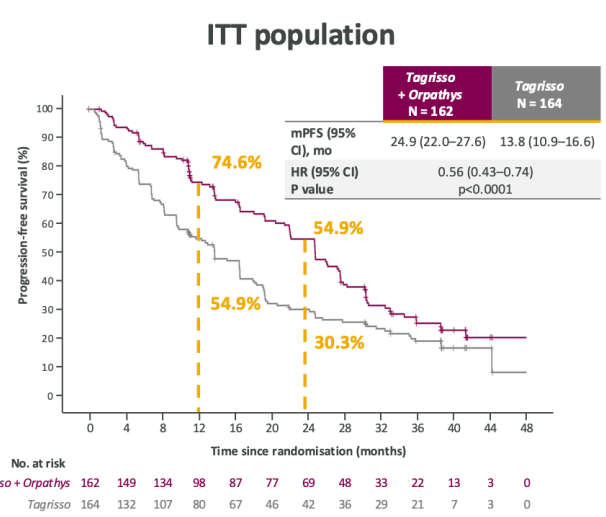
和黄医药/阿斯利康：奥希联合赛沃一线EGFRm伴MET过表肺癌mPFS达24.8个月

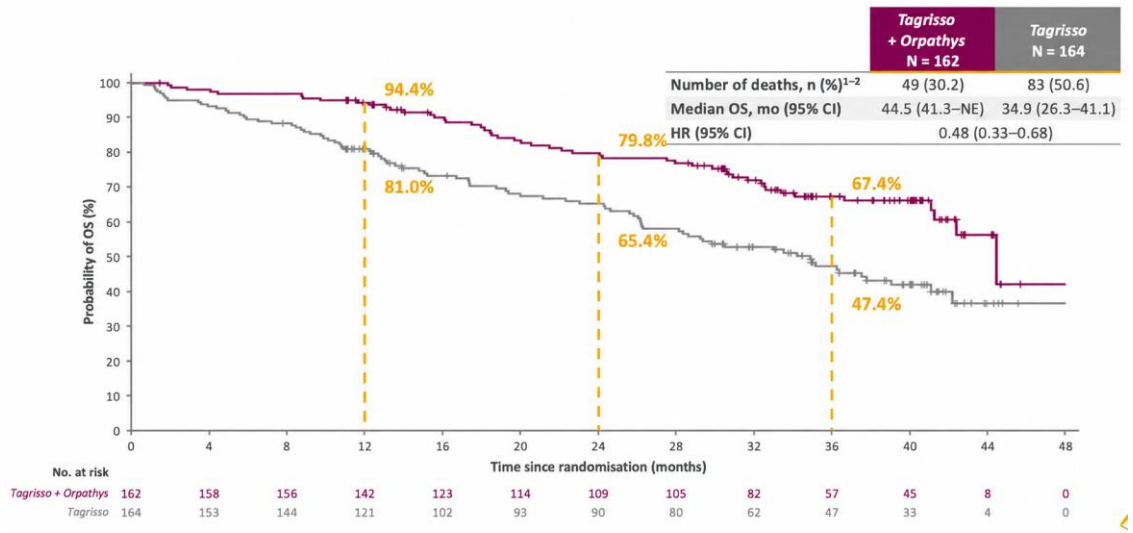
华创研究

- 既往研究观察到，对于初始即存在MET过表达（MET-OE）的EGFR突变型（EGFRm）晚期非小细胞肺癌（NSCLC）患者，一线使用EGFR-TKI单药的疗效有所降低。本次报告在中国开展的III期SANOVO研究（NCT05009836）的主要结果，该研究评估赛沃替尼联合奥希替尼，对比安慰剂联合奥希替尼，一线治疗EGFRm且MET过表达晚期NSCLC的疗效和安全性。
- 截至2026年7月31日， SANOVO研究共入组326例既往未接受治疗的伴有EGFR突变（Ex19del、L858R）的局部晚期或转移性NSCLC患者，且存在MET过表达（**MET IHC 2+或3+强度**），按1：1随机分配至赛沃替尼＋奥希替尼组（n=162）或安慰剂＋奥希替尼组（n=164）。随机分层因素包括 EGFR 突变类型、是否存在脑转移及 MET 过表达水平。主要终点为研究者评估的PFS，采用分层顺序检验：首先检验 MET IHC 3+人群；若结果阳性，再检验ITT全人群。
- 疗效方面，在MET IHC 3+亚组（n=98）中，经研究者评估，**赛沃替尼+奥希替尼组的PFS较对照组显著延长（24.8 vs 11.1个月，HR=0.45，P<0.0001）**；在**ITT人群中，经研究者评估，赛沃替尼+奥希替尼组的PFS获益显著（24.9 vs 13.8个月，HR=0.56，P<0.0001）**。此外，在ITT人群中，中位随访38.7个月时，赛沃替尼+奥希替尼组的OS显著延长（44.5 vs 34.9个月，HR=0.48）。
- 安全性方面，赛沃替尼+奥希替尼组和对照组的中位治疗暴露时间分别为22.1个月和12.9个月。两组因不良事件导致中止治疗的患者比例分别为14.8%和4.3%。

SANOVO研究PFS和OS数据







证监会审核：证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210

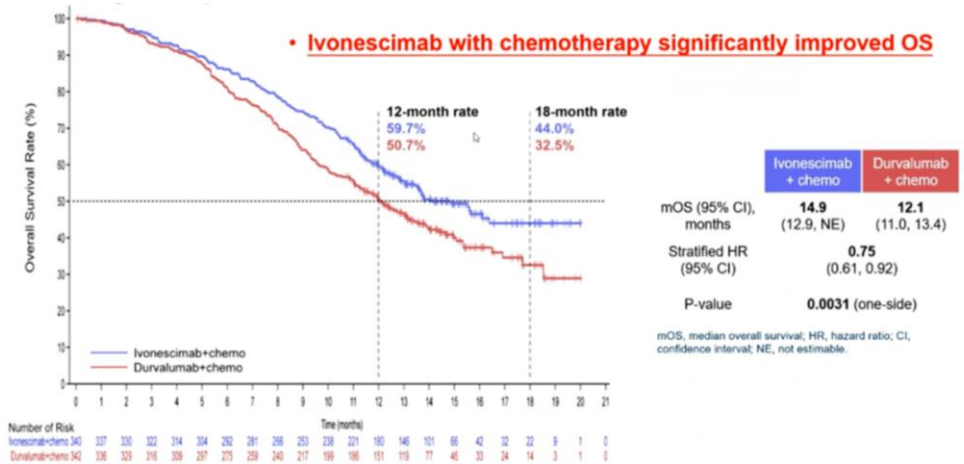
数据来源：阿斯利康 ESMO 2026 演示材料

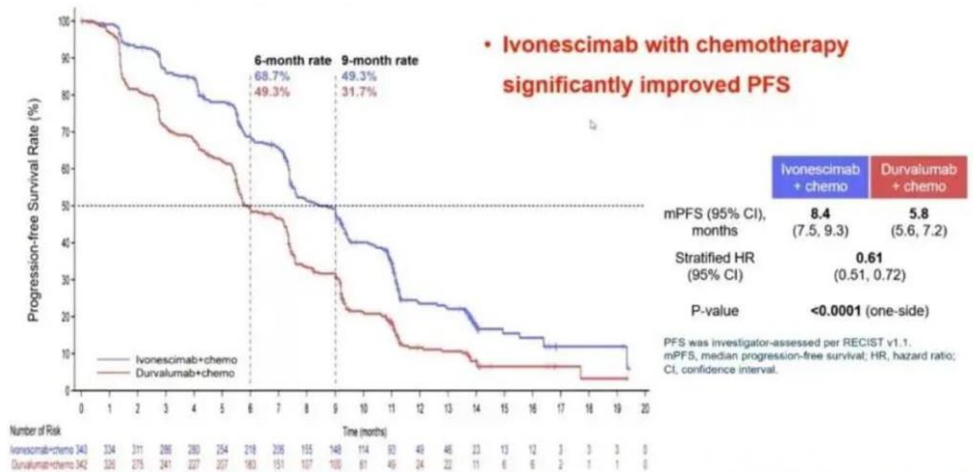
知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

康方生物：依沃西联合化疗头对头度伐利尤联合化疗一线治疗BTC III期OS阳性

- 胆道恶性肿瘤是来源于胆管及胆囊的一种高度异质性恶性肿瘤，预后差，约50%的胆道恶性肿瘤病人在确诊时已为进展期，生存期不足1年。帕博利珠单抗（PD-1）和度伐利尤单抗（PD-L1）联合化疗是国际晚期胆道癌的一线治疗方案，但总生存期的获益仍然有限。度伐利尤单抗/帕博利珠单抗联合化疗是目前国内外指南共同推荐的一线免疫最优治疗方案（ TOPAZ-1 研究）。
- AK112-309/HARMONi-GI1研究是一项随机、对照、双盲、多中心、注册性III期临床研究，旨在比较依沃西单抗联合化疗，对比度伐利尤单抗（PD-L1）联合化疗，用于一线治疗晚期胆道恶性肿瘤（BTC）的疗效与安全性。主要终点为OS，关键次要终点包括研究者评估的PFS与ORR。
- 在ITT中，依沃西联合化疗较度伐利尤单抗联合化疗显著延长患者的OS，两组中位OS分别为**14.9个月 vs 12.1个月，HR=0.75 (95% CI: 0.61–0.92)**，死亡风险降低25%，P=0.0031。依沃西组较对照组的生存获益随时间推移持续扩大。两组的12个月OS率分别为59.7% vs 50.7%，18个月OS率分别为44.0% vs 32.5%。两组中位PFS分别为8.4个月 vs 5.8个月，HR=0.61 (95% CI: 0.51–0.72)，P < 0.0001；依沃西组和度伐利尤单抗组6个月PFS率分别为68.7% vs 49.3%，9个月PFS率分别为49.3% vs 31.7%。两组的ORR分别为53.8% vs 32.5%，绝对差值达21.3%，P<0.0001；两组的DCR分别为91.5%和77.8%。
- 安全性方面，依沃西单抗联合化疗的安全性可控，且治疗药物暴露时间更长；所有级别及3/4级中最常见的不良事件为血液学毒性，未发现新的安全信号；依沃西组与度伐利尤单抗组的严重不良反应发生率相当，分别为43.4% vs 43.7%；任意级别和≥3级出血事件发生率相近，分别为9.7% vs 6.5%，以及 1.5% vs 1.8%，未增加不可控的出血风险。

HARMONi-GI1研究OS和PFS数据





数据来源：肿瘤瞭望消化时讯《ESMO重磅：依沃西联合化疗一线治疗晚期胆道癌总生存期头对头优于国际金标准》

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

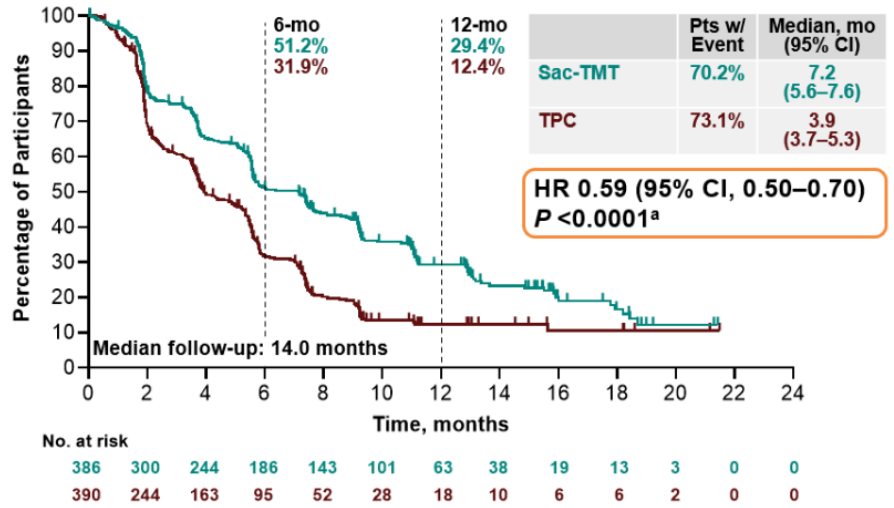
科伦博泰/默沙东：sac-TMT子宫内膜癌III期数据积极

华创研究

- TroFuse-005研究是一项随机、阳性药物对照、开放标签、多中心、全球临床试验（n=776），评估了芦康沙妥珠单抗（4mg/kg，Q2W）对比医生选择的化疗方案（TPC，多柔比星或紫杉醇）治疗既往接受过铂类化疗和PD-(L)1药物（联合或序贯，总治疗线数≤3线）治疗的子宫内膜癌患者的疗效和安全性。
- 截至2026年3月23日，中位随访时间为14.0个月。结果显示，芦康沙妥珠单抗组的PFS较TPC组显著延长**（7.2 vs 3.9个月，HR=0.59，P<0.0001）**，疾病进展或死亡风险降低41%；中位OS亦显著延长（19.0 vs 12.1个月，HR=0.68，P=0.0001），绝对获益近7个月，死亡风险降低32%。此外，两组的客观缓解率（ORR）分别为35.1%和17.3%，中位缓解持续时间（DOR）分别为11.1个月和6.9个月，中位DOR达到12个月的患者比例分别为42.9%和35.1%。
- 安全性方面，芦康沙妥珠单抗组和TPC的3级及以上治疗相关不良事件（TRAE）发生率分别为54.4%和41.4%，因TRAE中止治疗的患者比例分别为3.1%和4.9%，因TRAE死亡的患者比例均为0.8%。
- 基于此，该药物在美国的上市申请获得FDA受理并予以优先审评，PDUFA日期为2027年6月15日。

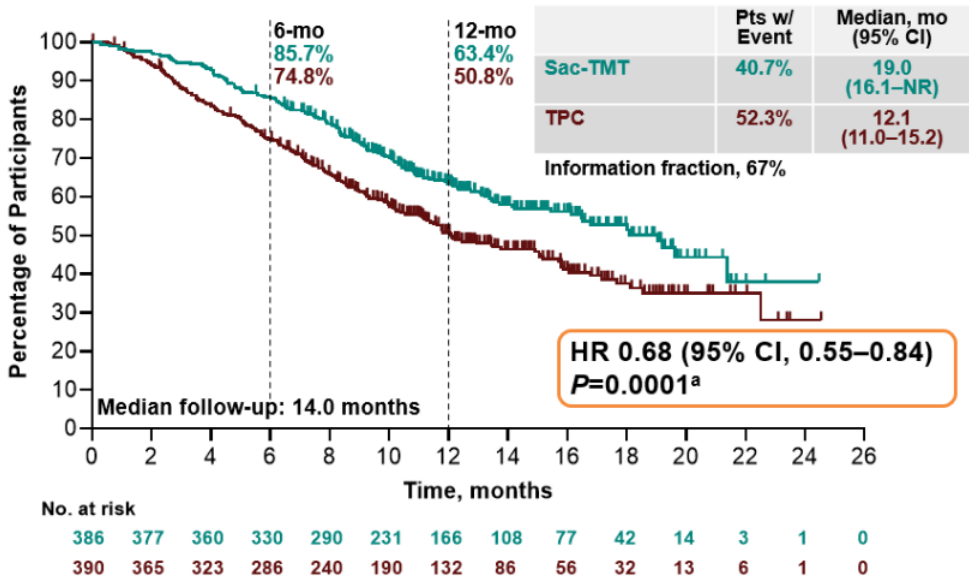
TroFuse-005研究疗效数据

PFS by BICR



Response assessed per RECIST v1.1 by BICR. aThe observed 1-sided log-rank test p-value met the prespecified boundary for significance (P=0.0025) at this interim analysis. Data cutoff date: March 23, 2026.

OS at IA



证监会审核：证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210

数据来源：默沙东ESMO Investor Event 演示材料

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

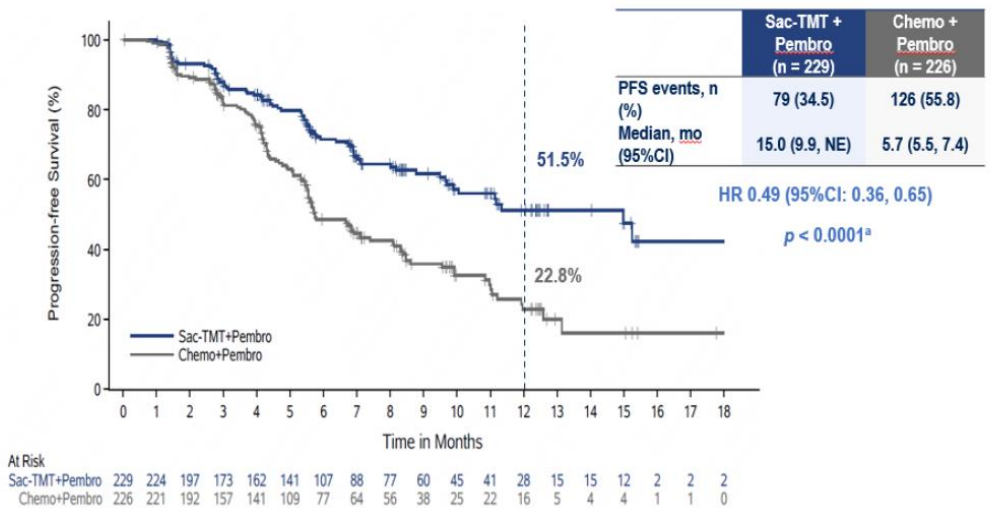
科伦博泰/默沙东：ADC+IO一线治疗PD-L1阴性nsq-NSCLC数据积极

华创研究

- 对于无可靶向基因改变、PD-L1阴性的晚期非鳞状非小细胞肺癌（nsq-NSCLC），帕博利珠单抗联合化疗是标准一线治疗方案，但中位PFS仅6-8个月左右(KEYNOTE-189研究），治疗效果仍有提升空间。sac-TMT是一种靶向TROP2 ADC药物，此前联合PD-1抑制剂在一线治疗PD-L1阳性非小细胞肺癌中显示出令人鼓舞的抗肿瘤活性。本次报告OptiTROP-Lung06研究（NCT06711900）预先计划的PFS期中分析结果。
- OptiTROP-Lung06研究是一项随机、多中心、开放标签III期研究，共纳入455例患者，按1:1比例随机接受sac-TMT联合帕博利珠单抗或含铂双药化疗联合帕博利珠单抗治疗。主要终点为BICR评估的PFS，次要终点包括OS等。
- 截至2026年6月9日，中位随访时间为9.7个月。与化疗+P相比，sac-TMT+P在BICR评估的PFS方面显示出显著改善**（中位PFS：15.0个月 vs 5.7个月；HR，0.49；95% CI 0.36-0.65）。p<0.0001）**。OS数据尚不成熟，但在sac-TMT联合治疗组中观察到有利趋势（HR=0.58）。经BICR评估，两组ORR分别为50.2%和47.3%，深度缓解率分别为28.8%和17.3%。
- 安全性方面，sac-TMT+P的安全性特征与各单药已知的安全性特征总体一致，未观察到新的安全性信号。与对照组相比，sac-TMT联合治疗组≥3级TEAE发生率较低（47.6% vs 60.6%）；导致剂量降低或永久停药的TEAE发生率也较低。两组间质性肺病/肺炎发生率相似。

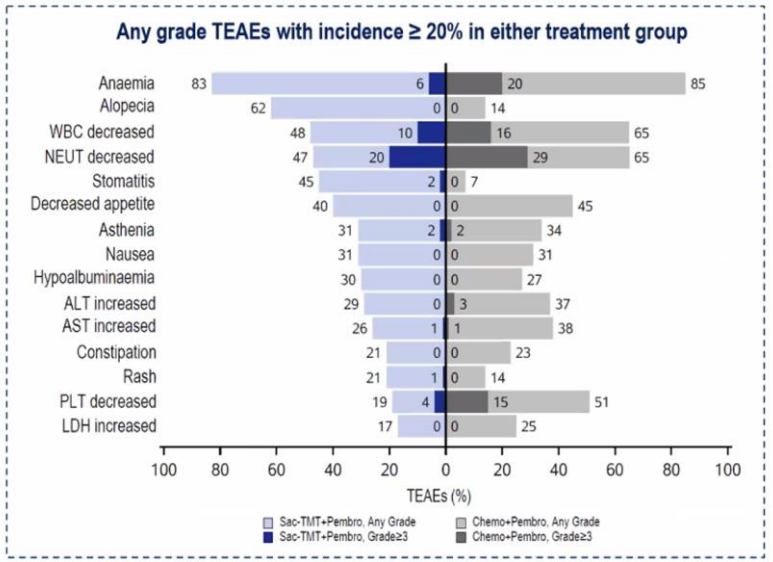
OptiTROP-Lung06研究PFS数据

PFS by BICR



	Sac-TMT + Pembro (n = 229)	Chemo + Pembro (n = 226)
PFS events, n (%)	79 (34.5)	126 (55.8)
Median, mo (95%CI)	15.0 (9.9, NE)	5.7 (5.5, 7.4)

OptiTROP-Lung06研究安全性数据



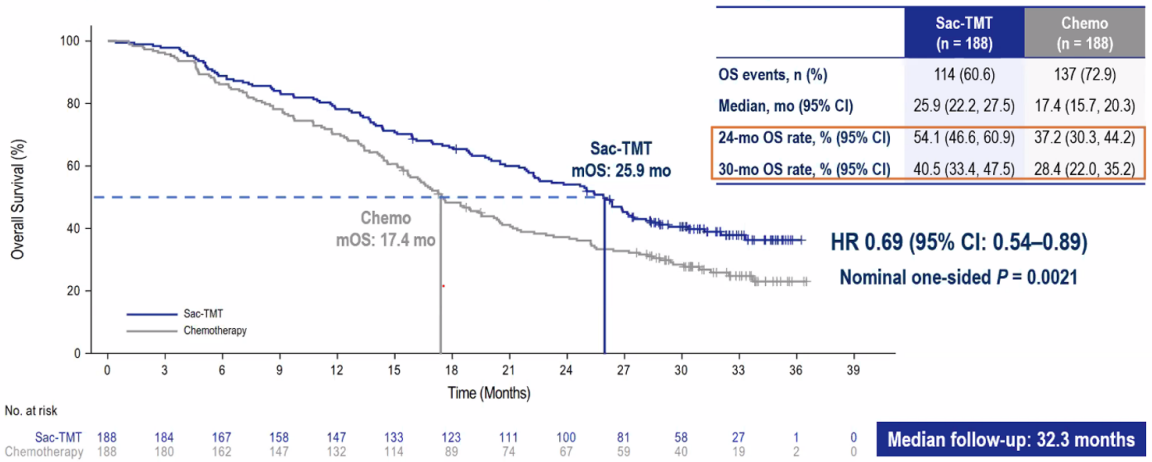
知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

科伦博泰/默沙东：sac-TMT二线治疗EGFRm NSCLC最终OS达25.9个月

华创研究

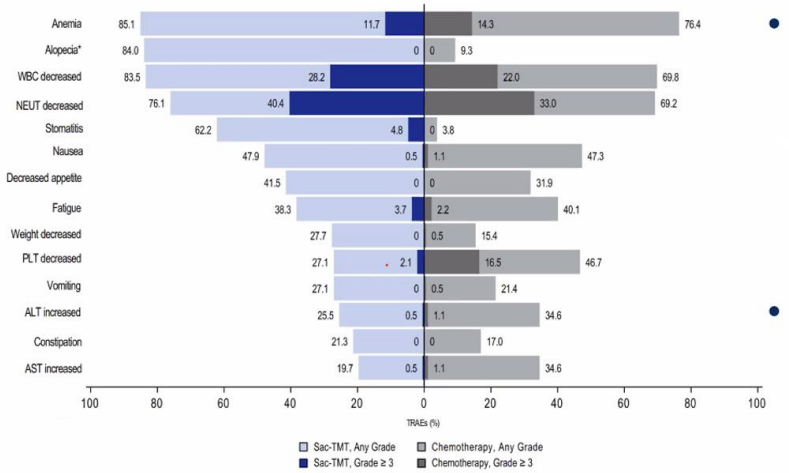
- 在III期OptiTROP-Lung04研究预先计划的OS期中分析中，对于接受EGFR-TKI治疗后疾病进展的EGFR突变型非小细胞肺癌（EGFRm NSCLC）患者，与含铂化疗相比，sac-TMT显著改善了PFS和 OS（Fang et al. NEJM 2025）。本次报告延长随访后预先计划的OS最终分析结果。
- 研究共随机分配376例患者，其中sac-TMT单药（5mg/kg，Q2W）入组188例，化疗组188例；。本次OS最终分析结果表明，中位随访32.3个月时，sac-TMT较含铂双药化疗显示出持续且具有临床意义的OS改善，**中位OS分别为25.9个月和17.4个月（HR=0.69；95% CI：0.54-0.89；p＜0.01）**，24月OS率分别为54.1%和37.2%。此外，含铂双药化疗组有22.6%的患者接受了后续ADC治疗，采用RPSFT模型对后续ADC治疗进行校正后，**中位OS分别为25.9个月 vs 16.6 个月，HR=0.57**（95% CI：0.42–0.75）。
- 安全性方面，延长随访后未发现新的安全性信号。芦康沙妥珠单抗(sac-TMT)组常见治疗相关不良事件主要为血液学不良事件和口腔黏膜炎。口腔黏膜炎以1–2级为主且可管理，3级事件发生率为4.8%。间质性肺病/肺炎在芦康沙妥珠单抗(sac-TMT) 组仅报告1例(0.5%)，在含铂双药化疗组报告2例(1.1%)，均为1–2级。

OptiTROP-Lung04研究最终OS数据



	Sac-TMT (n = 188)	Chemo (n = 188)
OS events, n (%)	114 (60.6)	137 (72.9)
Median, mo (95% CI)	25.9 (22.2, 27.5)	17.4 (15.7, 20.3)
24-mo OS rate, % (95% CI)	54.1 (46.6, 60.9)	37.2 (30.3, 44.2)
30-mo OS rate, % (95% CI)	40.5 (33.4, 47.5)	28.4 (22.0, 35.2)

OptiTROP-Lung04研究TRAE数据



证监会审核，证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210

数据来源：默沙东ESMO Investor Event 演示材料

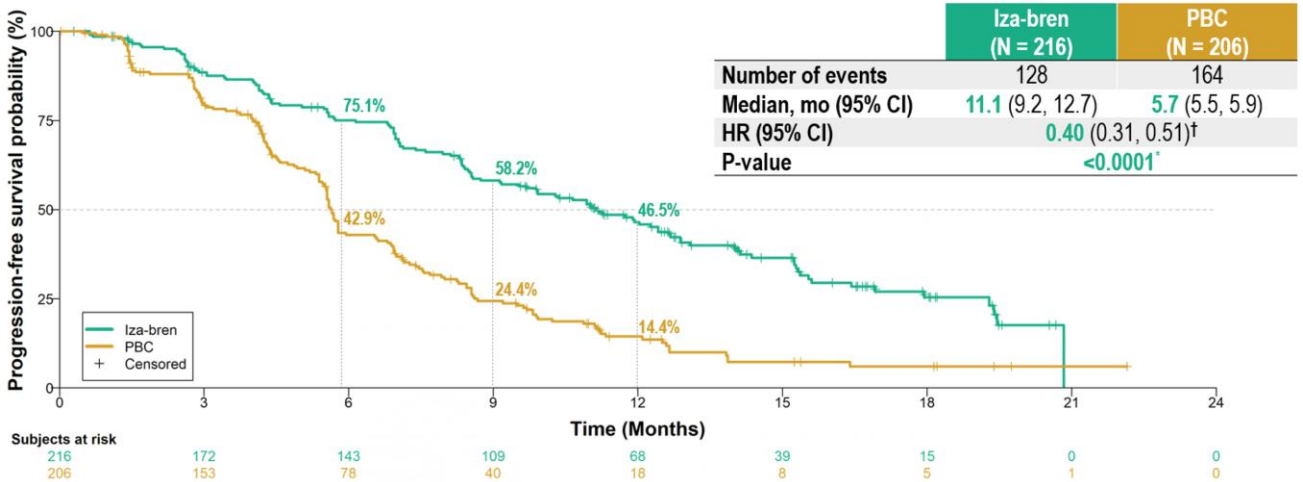
知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

百利天恒/BMS：Iza-bren肺癌二线mPFS 11.1个月，一线联合奥希ORR 100%

华创研究

- 截至2026年7月15日，PANKU-Lung01研究共入组432例患者，其中216例患者接受iza-bren 2.5mg/kg D1D8 Q3W治疗，206例患者接受含铂双药化疗。主要研究终点为BICR评估的PFS，关键次要终点为OS。
- 入组患者均为三代EGFR-TKI经治人群，且有9.7%的患者既往接受过抗血管生成治疗；76.4%的患者ECOG PS评分为1分，58.3%存在≥3个转移部位等，整体呈现“体力状态差、疾病负荷重、充分经治”的基线特征。
- 疗法方面，iza-bren组与化疗组mPFS分别为**11.1个月 vs 5.7个月（HR=0.40; 95% CI, 0.31-0.51; p <0.0001）**，为目前EGFRm二线治疗最长mPFS，疾病进展或死亡风险降幅最大；获益不受人群限制，所有亚组一致获益。cORR分别为60.2% vs 34.5%，超过60%的患者实现最佳应答，91.2%的患者实现靶病灶缩小，较基线中位缩瘤幅度达-46.8%，缩瘤率高，缩瘤幅度大。OS显示出明显的获益趋势（HR=0.66；95%CI，0.47–0.91），即使对照组近30%患者疾病进展后接受了ADC药物作为后续治疗，OS仍显示出明显的获益趋势。
- 安全性方面，无特殊需要关注的AE，停药率低。治疗组≥3级TRAE以血液学毒性为主，患者多无明显主观感受。不良反应谱清晰、可预期，临床处理经验丰富，无特殊需要关注的AE；因TRAE导致的治疗终止率仅1.9%，支持长期用药获益。

iza-bren PFS数据



	Iza-bren (N = 216)	PBC (N = 206)
Number of events	128	164
Median, mo (95% CI)	11.1 (9.2, 12.7)	5.7 (5.5, 5.9)
HR (95% CI)	0.40 (0.31, 0.51)†	
P-value	<0.0001*	

iza-bren安全性数据

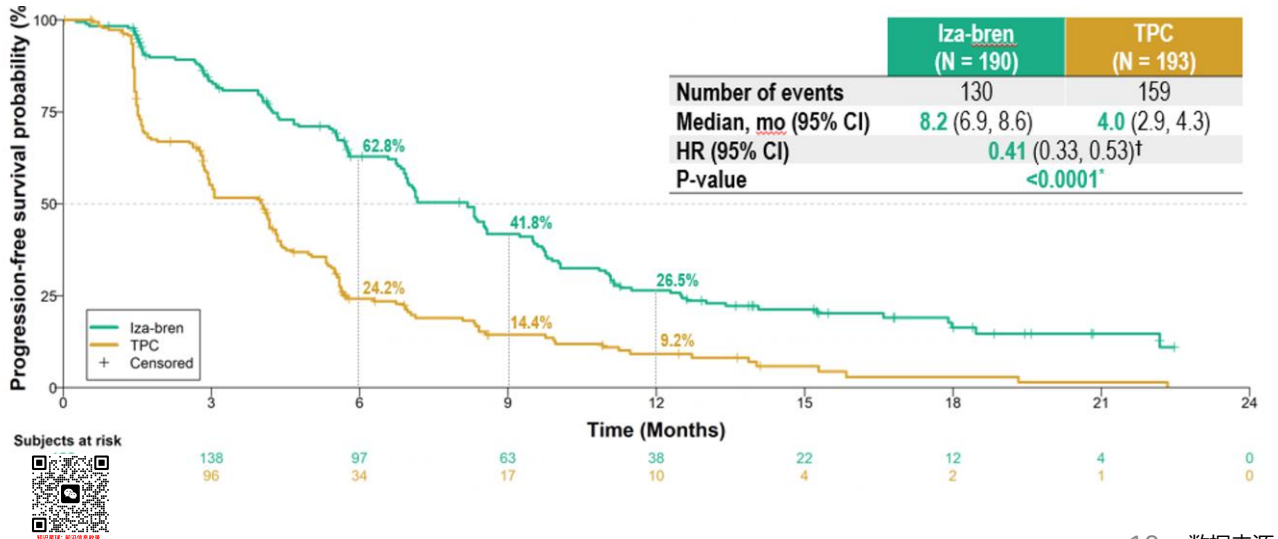
	Iza-bren (N = 216)	PBC (N = 206)
TRAEs, n (%)	216 (100)	204 (99.0)
≥Grade 3 TRAEs, n (%)	170 (78.7)	128 (62.1)
Treatment-related SAEs, n (%)	92 (42.6)	40 (19.4)
TRAEs leading to death, n (%)	1 (0.5)	1 (0.5)
TRAEs leading to treatment discontinuation, n (%)	4 (1.9)	4 (1.9)
TRAEs leading to dose reduction, n (%)	130 (60.2)	48 (23.3)
TRAEs leading to dose interruption, n (%)	116 (53.7)	49 (23.8)

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

百利天恒/BMS：Iza-bren HR+/HER2- BC III期临床结果积极

- 截至2026年7月21日，PANKU-Breast01研究共随机分组并治疗383例患者，其中190例接受iza-bren 2.5 mg/kg，D1、D8给药，每3周一个周期，193例接受医生选择的化疗方案。主要终点为BICR评估的PFS，次要终点包括OS；两组PFS中位随访分别为15.24个月和13.63个月，OS中位随访为17.8个月。
- PANKU-Breast01研究入组患者整体呈现“早期即高危、生物学偏侵袭、既往接受过治疗的多线经治、体力状态偏差”的难治特征：100%既往接受过CDK4/6抑制剂治疗，既往均接受过1-2线化疗（1线71.1%、2线28.9%），中位既往系统治疗线数3线（1-6线）；80.0%的患者既往接受过（新）辅助治疗、80.0%使用过蒽环类药物、55.8%接受过放疗，64.2%的患者ECOG评分为1分、71.6%存在肝转移。
- 疗效方面，iza-bren组与化疗组的mPFS分别为**8.2个月 vs 4.0个月（HR＝0.41；95%CI：0.33–0.53；P＜0.0001）**，中位PFS约翻倍、延长4.2个月，疾病进展或死亡风险降低59%。BICR评估的cORR为 40.5% vs 20.2%；mDoR为 6.9个月 vs 4.2个月。研究覆盖HER2 IHC 0、IHC 1+及IHC 2+/ISH−患者，为不同HER2阴性表达层次提供了治疗证据。OS尚未成熟，总生存获益仍待后续分析确认。
- 安全性方面，iza-bren的不良反应以血液学毒性为主，≥3级TRAE发生率为85.3% vs 65.8%，治疗相关严重不良事件为41.6% vs 11.4%，提示治疗过程中需要积极监测血象并给予支持治疗。因TRAE减量的比例为64.7% vs 28.5%，永久停药率为 1.6% vs 1.0%；**经裁定的ILD发生率为1.1%，均为1–2级。**整体呈现永久停药率较低、但骨髓抑制及剂量调整负担较明显的特点，疗效获益需要与毒性管理共同评估。

iza-bren PFS数据



	Iza-bren (N = 190)	TPC (N = 193)
Number of events	130	159
Median, mo (95% CI)	8.2 (6.9, 8.6)	4.0 (2.9, 4.3)
HR (95% CI)	0.41 (0.33, 0.53)†	
P-value	<0.0001*	

iza-bren安全性数据

	Iza-bren (N = 190)	TPC (N = 193)
TRAEs, n (%)	189 (99.5)	188 (97.4)
≥Grade 3 TRAEs, n (%)	162 (85.3)	127 (65.8)
Treatment-related SAEs, n (%)	79 (41.6)	22 (11.4)
TRAEs leading to death, n (%)	2 (1.1)	1 (0.5)
TRAEs leading to treatment discontinuation, n (%)	3 (1.6)	2 (1.0)
TRAEs leading to dose reduction, n (%)	123 (64.7)	55 (28.5)
TRAEs leading to dose interruption, n (%)	107 (56.3)	73 (37.8)

证监会审核，证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210

数据来源：百利天恒公众号

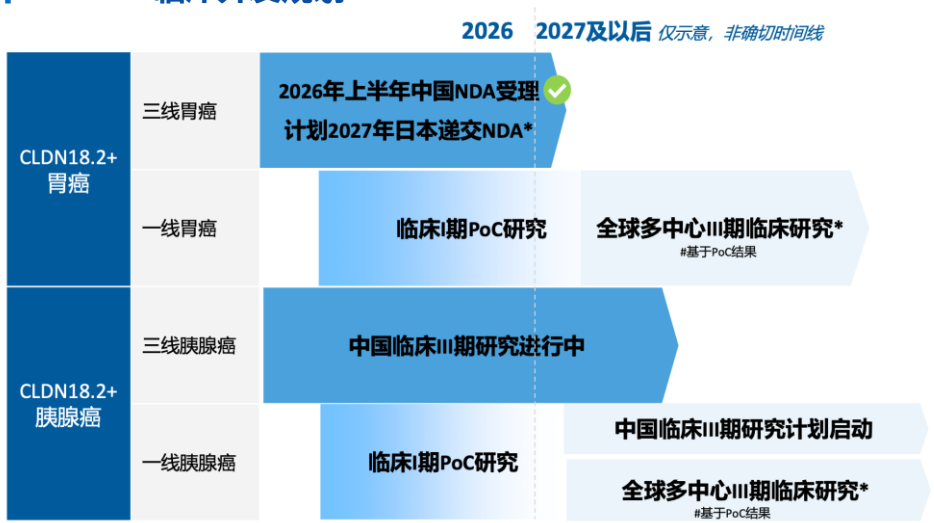
知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

信达生物/武田：IBI343三线CLDN18.2 G/GEJA取得PFS和OS双阳性结果

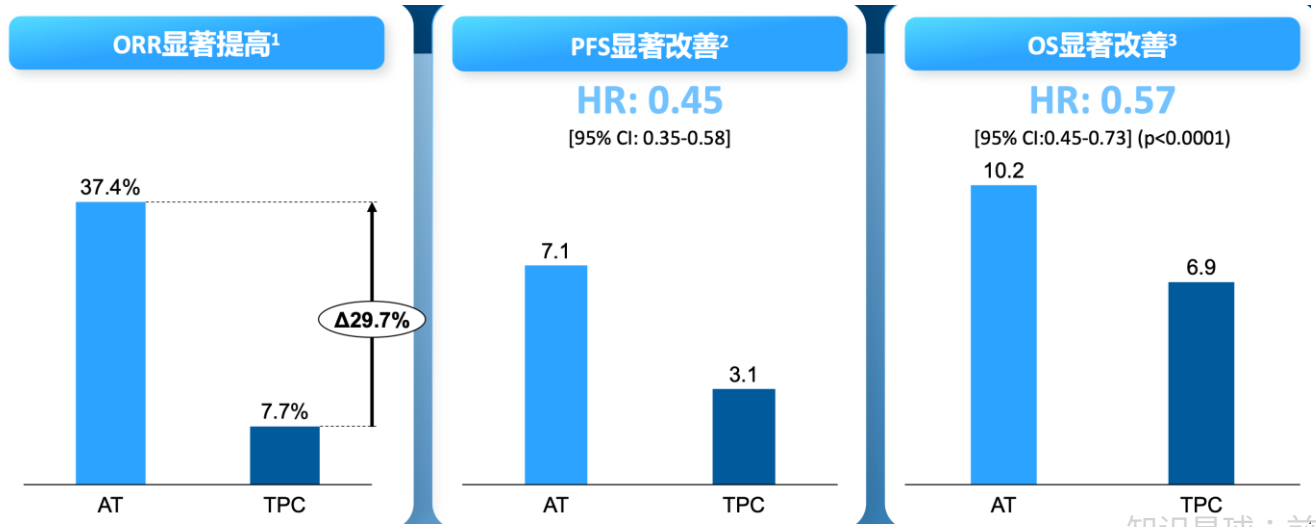
华创研究

- CLDN18.2是一种在某些癌细胞表面异常高表达的蛋白,已成为包括胃癌在内的部分消化道肿瘤的重要生物标志物。IBI343是一款Claudin18.2 ADC，采用依喜替康作为载荷，并采用Fc沉默骨架设计，以降低Fc介导效应的风险，DAR值为4。
- G-HOPE-001是一项在中国和日本开展的国际多中心、随机对照开放标签III期临床研究，旨在评估IBI343对比研究者选择的化疗方案在至少接受过两种系统性治疗的局部晚期不可切除或转移性CLDN18.2阳性G/GEJA受试者（CLDN18.2 在≥75%的肿瘤细胞中呈膜染色强度≥2+）中的疗效与安全性。
- 本次ESMO大会报告的数据来自方案预设的两次期中分析，第一次期中分析（IA1）为PFS的主要分析，第二次期中分析（IA2）为OS的主要分析，两次分析的数据截止时间分别为2026年2月13日和9月3日。与对照组相比，IBI343组在OS、PFS和ORR均取得具有统计学显著性和临床意义的改善：**IBI343组的mOS为10.2个月，对照组为6.9个月（HR=0.57, 95% CI: 0.45-0.73; P<0.0001）**。第一次期中分析结果显示，中位PFS达到方案预设的统计标准，呈现显著统计学差异及临床意义的改善。第二次期中分析结果，经IRRC评估，**相较对照组的3.1个月，IBI343组的mPFS为7.1个月，中位PFS获益进一步延长（HR=0.45, 95% CI: 0.35-0.58）**。IBI343组经IRRC评估后确认的ORR为37.4%，显著高于对照组的7.7%。
- 安全性方面， IBI343整体安全性特征可控，≥3级TRAE发生率为47.4%，而对照组为55.9%，严重胃肠道事件发生率较低，接受坦康阿妥塔单抗治疗的患者中，≥3级恶心、呕吐和腹泻的发生率分别为0.9%、2.6%和1.3%，对照组分别为1.8%、3.2%和4.1%。

IBI343临床开发规划



IBI343 G-HOPE-001临床结果



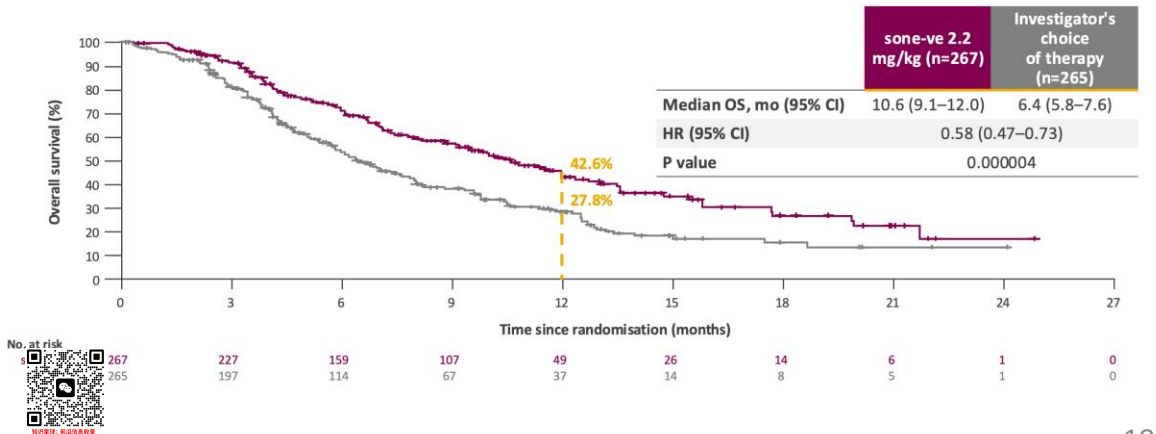
知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

康诺亚/乐普生物/阿斯利康：Sone-Ve治疗3L+ GEC三期研究OS达10.0个月

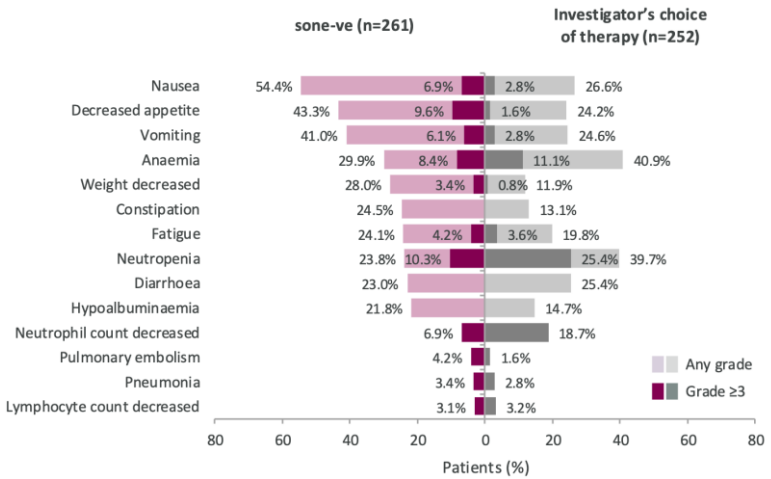
华创研究

- Sone-Ve是一种CLDN18.2 ADC药物，载荷为单甲基澳瑞他汀 E（MMAE），DAR值为4。
- CLARITY-Gastric01（CG-01）是一项随机、开放标签、全球性III期研究，旨在比较Sone-Ve与研究者选择疗法（INV）在既往接受过≥1线治疗的GEC患者中的疗效。2L+不可切除、局部晚期/转移性CLDN18.2阳性GEC患者（**要求CLDN18.2在≥25%的肿瘤细胞中呈膜染色阳性（任何强度）**）按1:1:1随机分配至Sone-Ve 1.8mg/kg、Sone-Ve 2.2 mg/kg或INV组。在剂量选择后，患者按1:1随机分配至Sone-Ve 2.2mg/kg或INV组（2L：雷莫西尤单抗+紫杉醇、紫杉醇或多西他赛；3L+：伊立替康、曲氟尿苷替匹嘧啶或阿帕替尼[仅中国]）。双主要终点为3L+人群的OS和ITT人群经BICR评估的PFS，关键次要终点为ITT人群的OS。
- 截至2026年5月31日，共有532例被随机分配至Sone-Ve 2.2mg/kg组 (n=267) 或INV组 (n=265)；中位随访时间为 8.6 个月。Sone-Ve 2.2 mg/kg在**3L+人群中较INV显著改善OS（中位10.0 vs 5.0个月，HR=0.47[95%CI 0.36–0.62]；p<0.001）**，在**2L+ ITT人群中也同样显著（中位10.6 vs 6.4个月，HR=0.58 [95%CI 0.47–0.73]；p<0.001）**。ITT人群经BICR评估的PFS未达到统计学显著性阈值（4.2 vs 3.8个月；HR=0.77 **[95%CI 0.62–0.96]**；p=0.05）。ITT人群的OS获益在CLDN18.2 ≥75%（HR=0.59）和25–75%（HR=0.63）表达亚组中保持一致。
- 安全性方面，Sone-Ve组3级及以上TRAEs发生率为36.4%，对照组为44.8%，整体安全性与耐受性良好。2023年，阿斯利康以6300万美元首付款从康诺亚/乐普合资公司KYM Biosciences获得Sone-Ve的授权，潜在里程碑付款最高可达11亿美元。阿斯利康预计产品销售峰值为30-50亿美元。
- 目前，Sone-Ve还在开展一项针对一线治疗的III期临床试验CLARITY-Gastric02，并于9月投资Summit12%股权，探索Sone-Ve联合依沃西单抗在GI肿瘤领域的潜力。

Sone-Ve治疗2L+ GEC OS数据



Sone-Ve治疗2L+ GEC 安全性数据



证监会审核，证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210

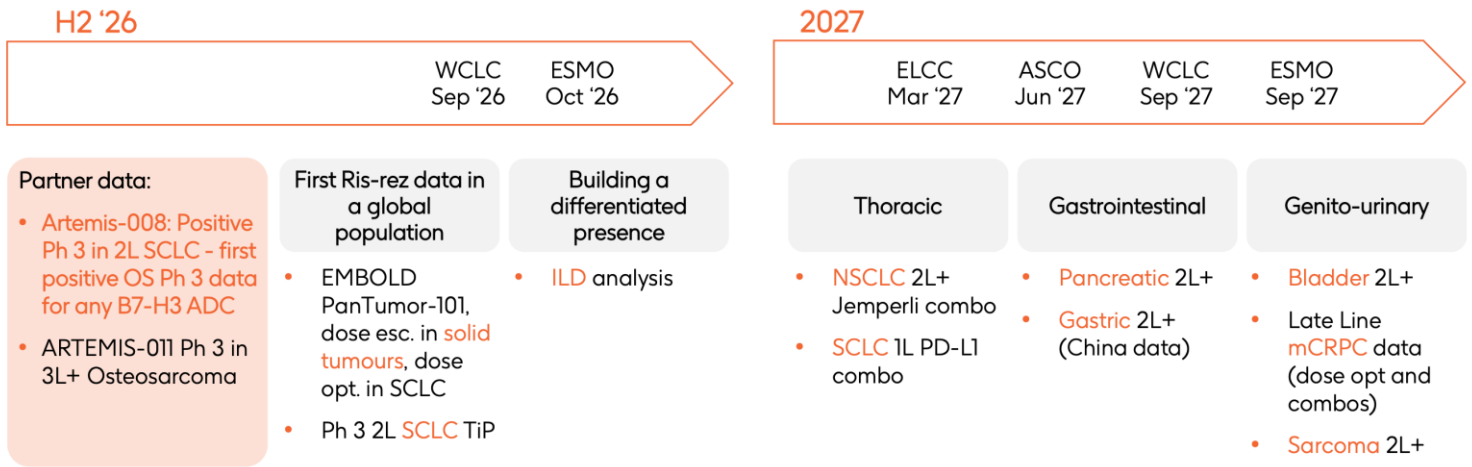
数据来源：阿斯利康 ESMO 2026 演示材料

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

翰森制药/GSK：B7-H3 ADC治疗复发/难治骨肉瘤III期结果积极

- Ris-Rez（HS-20093）是翰森研发的靶向B7-H3 ADC药物，由全人源抗B7-H3单克隆抗体与拓扑异构酶I抑制剂（TOP1i）有效载荷通过可裂解四肽连接子偶联而成。在中国，瑞康立伏妥塔单抗目前正在小细胞肺癌、非小细胞肺癌、骨肉瘤和食管鳞癌等适应症中开展关键性III期研究。
- ARTEMIS-011是一项多中心、开放标签、随机对照III期研究，共纳入122例至少二线治疗失败的复发或难治性（R/R）骨肉瘤患者，随机分配接受HS-20093（12.0mg/kg，Q3W）或吉西他滨联合多西他赛治疗。
- 截至2026年6月17日，中位随访时间为7.1个月， HS-20093组经BICR评估**mPFS为5.5个月，对照组为1.4个月（HR=0.33; 95%CI: 0.20-0.55, P<0.0001）**，研究者评估的PFS显示一致的获益趋势（5.6个月 vs 1.0个月，HR=0.30; 95%CI: 0.19-0.50, P<0.0001）。全部预设亚组中，均观察到与总体人群一致的获益。HS-20093组ORR为15%（对照组2%），DCR为76%（对照组33%）；mDOR为7.6个月。OS数据尚不成熟，但已显示数值上的获益趋势（两组中位OS均未达到；HR=0.51; 95%CI：0.21–1.23）。 ARTEMIS-011为近30年来复发或难治性骨肉瘤领域首个取得阳性结果的III期研究
- 安全性方面： HS-20093在既往至少二线治疗失败的复发或难治性骨肉瘤患者中显示出总体可控的安全性特征。两组最常见TRAE均为血液学事件，且均未发生5级（致死性）事件。 HS-20093组≥3级TRAE发生率为93%（对照组83%），严重TRAE发生率为64%（对照组29%），均以血液学事件为主；考虑到该组治疗持续时间显著更长（中位4.5个月 vs 1.5个月），暴露调整后总体可管理。仅HS-20093组1例患者发生2级治疗相关间质性肺病（ILD），经对症治疗后恢复。

Ris-Rez开发规划



知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

翰森制药/GSK：B7-H4 ADC治疗PROC单药中位PFS高达11.1个月

华创研究

- B7-H4是一种跨膜蛋白，在妇科肿瘤中广泛表达、正常组织低表达，兼具免疫调节与促瘤功能，是有前景的治疗靶点。Mo-Rez是由人源化抗B7-H4 IgG1单抗偶联拓扑异构酶I抑制剂组成的ADC。BEHOLD-1结果显示，在铂耐药卵巢癌（PROC）及晚期/复发子宫内膜癌患者中抗肿瘤活性显著。
- BEHOLD-1为两部分、开放标签I期研究（NCT06431594），Ib期临床中，PROC患者随机接受3个Mo-Rez剂量水平（2.8、4.8或5.8mg/kg，Q3W）。主要终点为研究者按 RECIST 1.1 评估的cORR。
- 截至2026年6月30日，剂量选择阶段共入组136例PROC，中位既往治疗线数为2线（范围：1–5线）。中位随访13.4个月时，**5.8mg/kg剂量组的cORR为62%（95%CI：46.5-76.2）**，与其他剂量组相比，该剂量组的DoR为12.2个月，**mPFS为11.1个月**，均优于其他剂量。
- 安全性方面，在至少接受过一次Mo-Rez治疗的135例患者中，所有剂量组共有64例（47%）患者发生≥3级TRAE，而接受5.8 mg/kg Mo-Rez治疗的患者中有32例（71%）发生≥3级TRAE。因TRAE导致的治疗中断率较低（总体剂量选择中为3%；接受5.8 mg/kg剂量的患者中为2%）。

Mo-Rez疗效数据

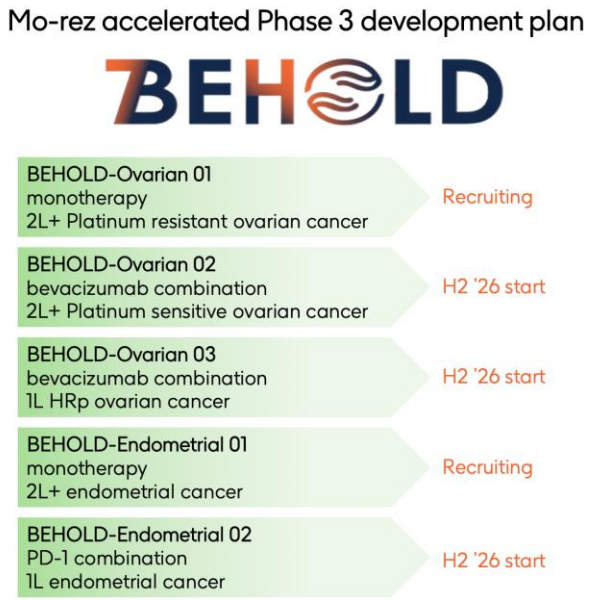
	Mo-Rez dose，Q3W		
	2.8 mg/kg (N=45)	4.8 mg/kg (N=46)	5.8 mg/kg (N=45)
Median follow-up, mos	13.4	13.4	13.4
Confirmed ORR, % (n) [95% CI]	36 (16) [21.9, 51.2]	57 (26) [41.1, 71.1]	62 (28) [46.5, 76.2]
Median DoR, mos [95% CI]	7.8 [4.4, NE]	6.9 [5.7, 9.7]	12.2 [7.0, 12.7]
Median PFS, mos [95% CI]	5.6 [4.0, 5.8]	8.3 [7.4, 10.9]	11.1 [8.3, 13.9]

Mo-Rez临床开发规划

15 months from Phase 1b to Phase 3 start

>600 patients dosed across BEHOLD trials

5 Phase 3 BEHOLD trials initiating in 2026



证监会审核：证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210

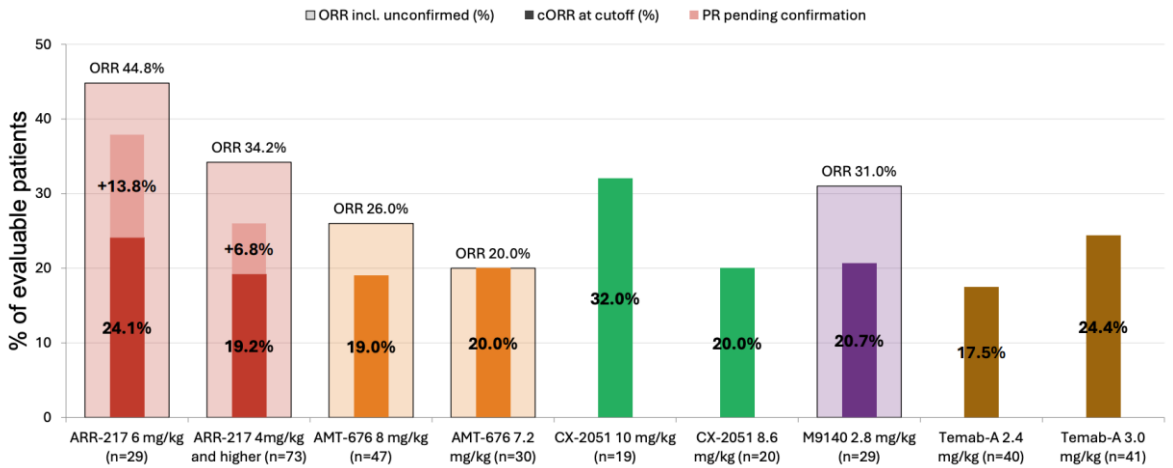
数据来源：2026 ESMO官网，GSK Q2 Results & Accelerate Growth 演示材料，华创证券

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

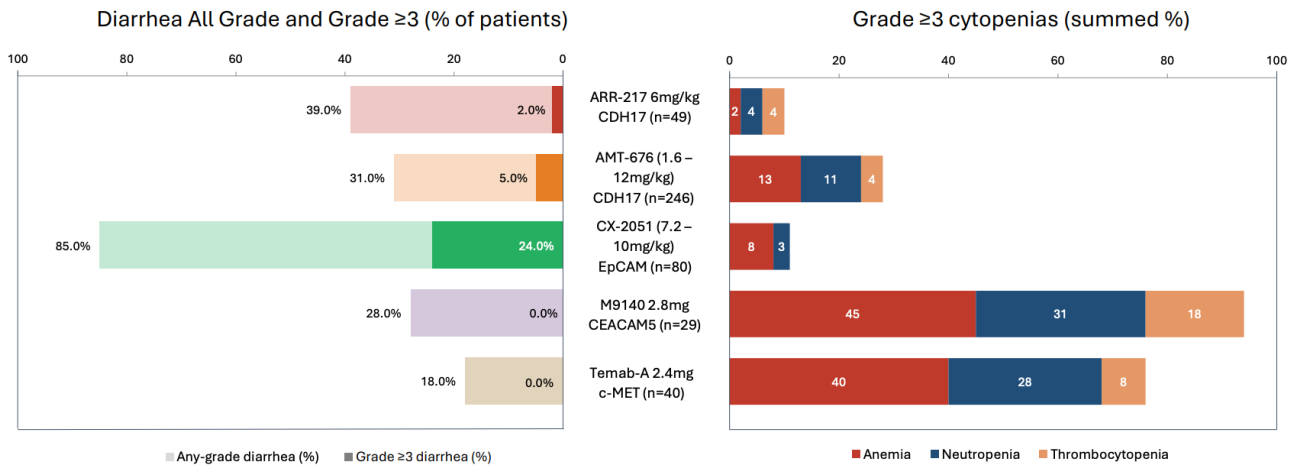
乐普生物：CDH17 ADC肠癌单药ORR44.8%，全球潜在同类最佳

- 标准化疗后，晚期CRC、PDAC及其他胃肠道恶性肿瘤患者的治疗选择仍然有限。钙黏蛋白-17（CDH17）在CRC及其他GI肿瘤中常过表达，是有吸引力的ADC靶点。MRG007是靶向CDH17的ADC，采用亲水、糖链连接、定点偶联设计，载荷为依喜替康，DAR为4。临床前数据显示其稳定性增强、内化迅速、细胞毒作用强且具有旁观者效应，并在包括低CDH17表达在内的CRC PDX模型中表现出稳健抗肿瘤活性。
- MRG007-001（NCT07066657）为在中国与美国开展的I期研究，包括剂量递增/回填，随后在CRC及其他GI肿瘤中进行剂量优化/扩展队列。符合条件的标准治疗后晚期/转移性实体瘤患者每3周一次接受MRG007静脉滴注，扩展阶段主要疗效终点为按RECIST v1.1的ORR。
- 截至2026年8月5日，研究共入组123例，其中CRC 113例。剂量递增已完成（2、4、6、8 mg/kg），4–8mg/kg回填仍在进行，CRC随机剂量优化已启动。最常见TEAE为血细胞减少和胃肠道毒性，以1或2级为主。未报告间质性肺病（ILD）；因TEAE停药1例（0.8%）。
- **在6mg/kg（RP2D）可评估疗效的CRC患者中，ORR为44.8%（13/29；95%CI 26.4%–64.3%）**，包括7例已确认PR及4例待确认PR，DCR为93.1%（27/29）。RAS野生型与突变型亚组均见缓解，ORR分别为50.0%（4/8）与42.1%（8/19）。在≥4mg/kg可评估疗效的CRC患者中，ORR为34.2%（25/73；95%CI 23.5%–46.3%）。

不同ADC在CRC中的ORR数据



不同ADC在CRC中的安全性数据



数据来源：ARRIVENT ARR-217 PHASE 1 DATA 演示材料（注：ORR统计2例待确认PR已退出研究）

证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

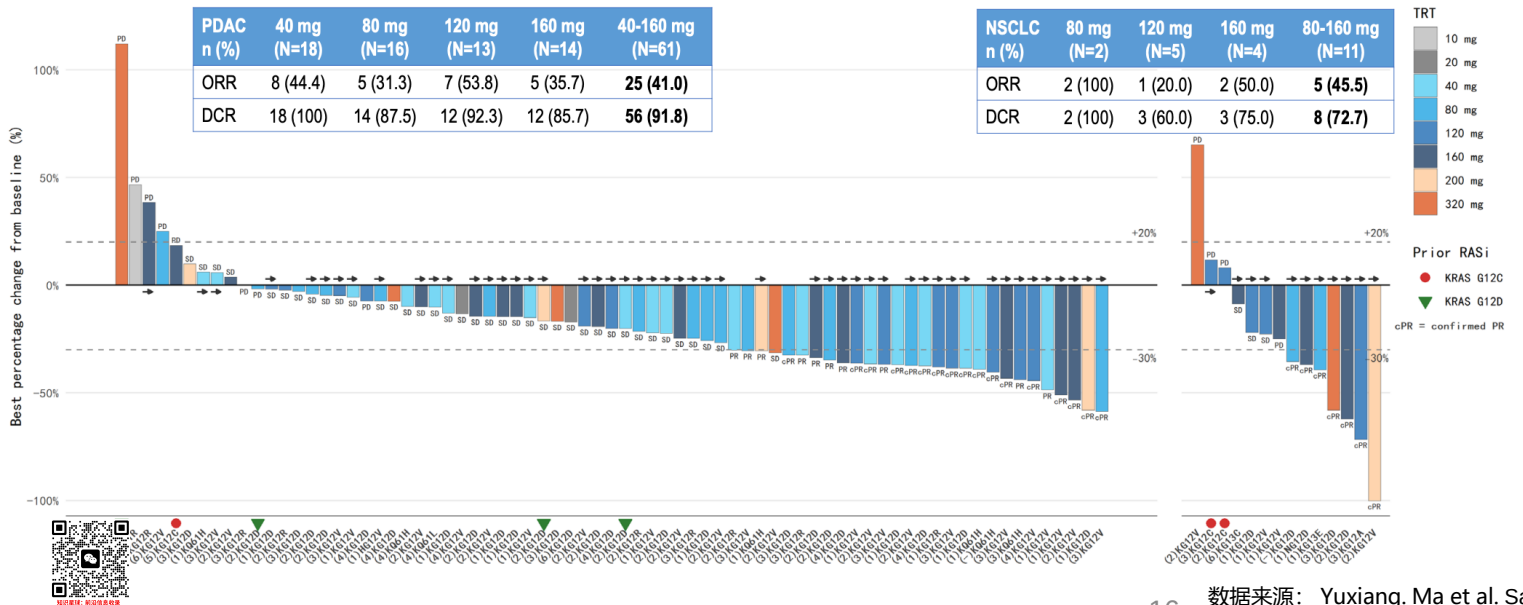
劲方医药：GFH276三线PDAC单药ORR为41.0%

- GFH276 是一种创新的口服pan-RAS（ON）抑制剂。GFH276单药研究（NCT07198321）Ia期为剂量递增阶段，入组患者覆盖广泛的RAS突变亚型，主要瘤种为PDAC、NSCLC和结直肠癌（CRC），剂量水平包括5-320 mg QD单药治疗。Ia期试验中，72.6%的胰腺导管腺癌(PDAC)患者、及61.1%的非小细胞肺癌(NSCLC)患者，入组后接受GFH276单药作为3线或以上治疗。
- 疗效方面，截至2026年9月15日，61名PDAC患者（40-160mgQD）完成至少一次治疗后肿瘤评估，**总体ORR为41.0%**、DCR为91.8%；11名NSCLC患者（80-160mgQD）完成至少一次治疗后肿瘤评估，**总体ORR为45.5%**、DCR为72.7%。数据显示GFH276药代动力学特征良好，未观察到显著药物蓄积，其初步临床疗效与临床前单药治疗的动物抑瘤结果相印证。此外，临床数据显示GFH276拥有较宽的治疗窗口、亦与临床前发现相印证—多瘤种动物模型显示GFH276与标准治疗（包括EGFR单抗、化疗或免疫治疗）联用可协同增效，为联合用药的临床策略提供依据。
- 安全性方面，截至2026年7月15日，80名患者接受40-160mgQD剂量水平的GFH276单药治疗，安全性/耐受性良好：多数TRAEs为1-2级，最常见TRAEs包括皮疹类、贫血、口腔黏膜炎、腹泻等；**3级TRAEs主要为皮疹类（7.5%），其他3级TRAEs的单项发生率均低于4%。**各级TRAEs整体可控、无4-5级TRAEs。目前GFH276已获批开展多种一线或后线联合疗法的临床试验，适应症包括PDAC、CRC及NSCLC。

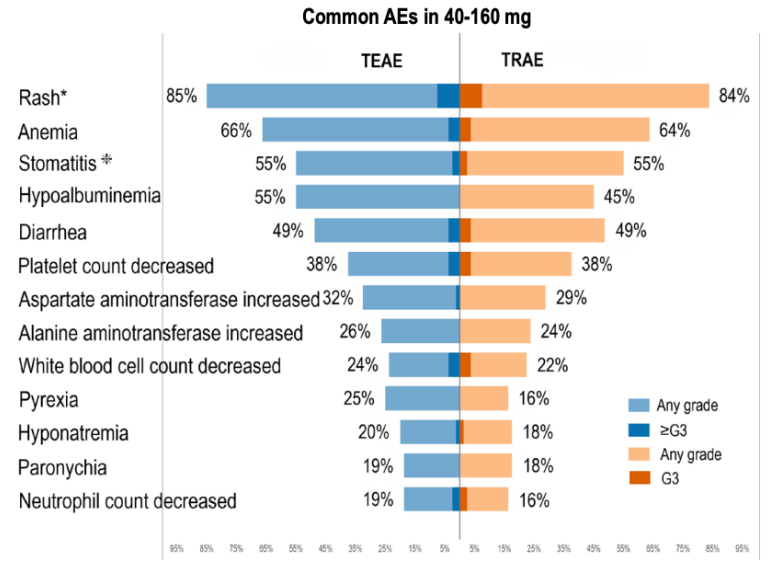
GFH276疗效数据

PDAC n (%)	40 mg (N=18)	80 mg (N=16)	120 mg (N=13)	160 mg (N=14)	40-160 mg (N=61)
ORR	8 (44.4)	5 (31.3)	7 (53.8)	5 (35.7)	**25 (41.0)**
DCR	18 (100)	14 (87.5)	12 (92.3)	12 (85.7)	**56 (91.8)**

NSCLC n (%)	80 mg (N=2)	120 mg (N=5)	160 mg (N=4)	80-160 mg (N=11)
ORR	2 (100)	1 (20.0)	2 (50.0)	**5 (45.5)**
DCR	2 (100)	3 (60.0)	3 (75.0)	**8 (72.7)**



GFH276安全性数据



数据来源： Yuxiang. Ma et al. Safety and Efficacy of GFH276 Monotherapy in Previously Treated RAS-mutated Advanced Solid Tumors

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

恒瑞医药：64项研究成果入选2026 ESMO，3项LBA

华创研究

- 本届ESMO恒瑞医药共有64项抗肿瘤及相关领域研究成果入选，共涉及21款创新药。包括3项优选论文口头报告（Proffered Paper）、3项快速口头报告（Rapid Oral）、32项壁报（Poster）和26项电子壁报（e-Poster），其中有3项最新突破性摘要（Late-Breaking Abstract，LBA）。研究覆盖乳腺癌、肺癌、消化系统肿瘤、妇科肿瘤、泌尿系统肿瘤、头颈部肿瘤及肿瘤支持治疗等多个领域，涉及到的1类新药产品包括：

➢ **9款已上市创新药-** **瑞康曲妥珠单抗（HER2 ADC）**、卡瑞利珠单抗（PD-1）、阿得贝利单抗（PD-L1）、阿帕替尼（VEGFR2）、吡咯替尼（EGFR/HER2/HER4）、达尔西利（CDK4/6）、氟唑帕利（PARP1/2）、海曲泊帕乙醇胺（TPO-R）、瑞拉芙普α（PD-L1/TGF-β）。

➢ **12款在研创新药-** **SHR-A2009 （HER3 ADC）**、HRS-7058（KRAS G12C抑制剂）、**HRS-4642（KRAS G12D抑制剂）**、SHR-A2102（Nectin-4 ADC）、SHR-A1904（Claudin 18.2 ADC）、SHR-1826（c-Met ADC）、SHR-4394（PSMA ADC）、SHR-4849（DLL3 ADC）、SHR-7787（DLL3/CD3双抗）、SHR-8068（CTLA-4单抗）、SHR-9839（EGFR/c-Met双抗）和SHR-3821 （CLDN18.2/4-1BB双抗）。

恒瑞医药2026 ESMO相关摘要（不包含e-Poster）

产品	领域	细分领域	摘要号	类型	产品	领域	细分领域	摘要号	类型
瑞康曲妥珠单抗	乳腺癌	乳腺癌	LBA13	Proffered paper	SHR-4849	肺癌	小细胞肺癌	3815P	Poster
吡咯替尼	乳腺癌	乳腺癌	560P	Poster	SHR-7787	肺癌	小细胞肺癌和神经内分泌癌	3825P	Poster
吡咯替尼	乳腺癌	乳腺癌	1772P	Poster	卡瑞利珠单抗	消化肿瘤	直肠癌	3530O	Proffered paper
达尔西利+吡咯替尼	乳腺癌	乳腺癌	1775P	Poster	HRS-4642±阿得贝利单抗	消化肿瘤	胰腺癌	LBA85	Rapid oral
瑞康曲妥珠单抗	乳腺癌	乳腺癌	1778P	Poster	卡瑞利珠单抗	消化肿瘤	胆道癌	466P	Poster
吡咯替尼	乳腺癌	乳腺癌	1781P	Poster	SHR-8068+阿得贝利单抗	消化肿瘤	胆道癌	467P	Poster
SHR-A2102	乳腺癌	乳腺癌	1847P	Poster	SHR-A1904+阿得贝利单抗	消化肿瘤	胃癌	2912P	Poster
达尔西利	乳腺癌	乳腺癌	1849P	Poster	阿得贝利单抗	消化肿瘤	食管鳞癌	2916P	Poster
SHR-A2009	肺癌	非小细胞肺癌	LBA72	Proffered paper	HRS-4642	消化肿瘤	胰腺癌	3150P	Poster
阿得贝利单抗	肺癌	非小细胞肺癌	2533P	Poster	卡瑞利珠单抗	消化肿瘤	胰腺癌	3156P	Poster
SHR-A2102	肺癌	非小细胞肺癌	2634P	Poster	HRS-4642+阿得贝利单抗+SHR-8068	消化肿瘤	胰腺癌	3157P	Poster
阿得贝利单抗	肺癌	非小细胞肺癌	2648P	Poster	伊立替康脂质体（II）	消化肿瘤	胰腺癌	3159P	Poster
HRS-4642+阿得贝利单抗	肺癌	非小细胞肺癌	2653P	Poster	HRS-4642+阿得贝利单抗	消化肿瘤	胰腺癌	3165P	Poster
SHR-1826+阿得贝利单抗+SHR-8068	肺癌	非小细胞肺癌	2659P	Poster	SHR-A2102	妇科肿瘤	宫颈癌	1244RO	Rapid oral
瑞康曲妥珠单抗±阿得贝利单抗	肺癌	非小细胞肺癌	2662P	Poster	阿帕替尼	其他	胸腺上皮肿瘤	4155RO	Rapid oral
SHR-A2009+阿得贝利单抗	肺癌	非小细胞肺癌	2663P	Poster	SHR-9839	其他	实体瘤	1031P	Poster
海曲泊帕	支持治疗	肿瘤治疗相关血小板减少症	3941P	Poster	HRS-7058	其他	实体瘤	1061P	Poster
阿帕替尼	其他	肺转移性骨肉瘤	4315P	Poster	卡瑞利珠单抗+阿帕替尼	其他	眼部肿瘤	1968P	Poster
伊立替康脂质体（II）+阿帕替尼	其他	横纹肌肉瘤	3736P	Poster	SHR-4394	泌尿肿瘤	前列腺癌	2228P	Poster

数据来源：恒瑞医药公众号，华创证券（注：红色为入选LBA创新药）

证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210

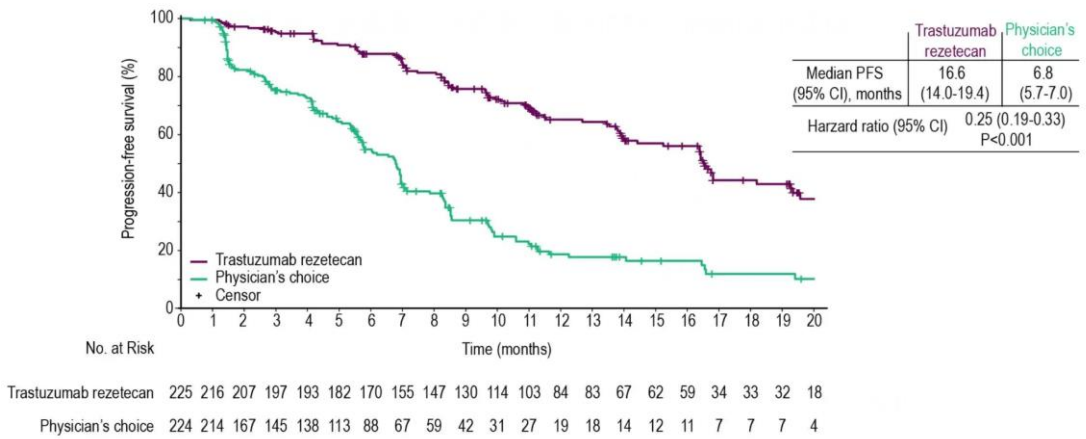
知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

恒瑞医药：SHR-A1811读出HER2低表达BC III期临床数据

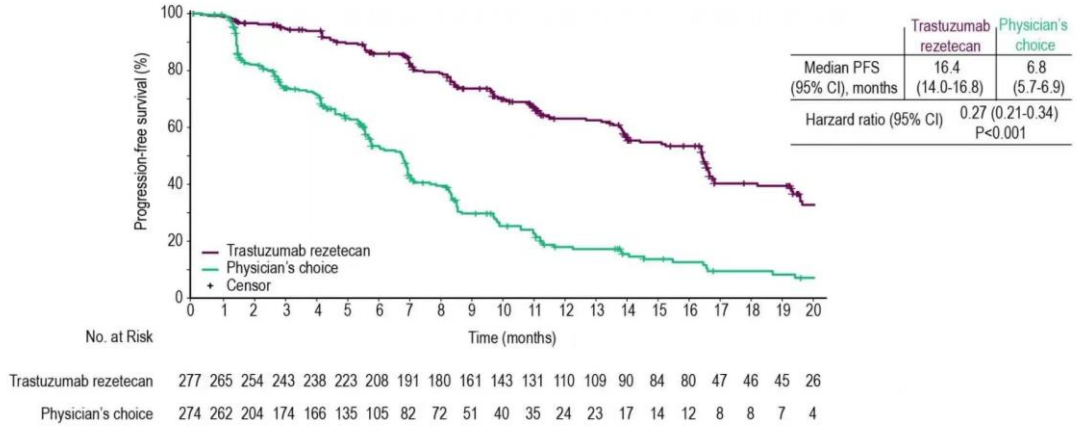
华创研究

- HER2低表达乳腺癌占全部乳腺癌人群45%-55%，是晚期乳腺癌庞大的患者群体。传统HER2靶向药物对此类人群获益有限，既往临床主要依靠化疗、内分泌治疗进行疾病管理，整体预后有待改善。SHR-A1811是恒瑞自研的HER2 ADC，毒素为拓扑异构酶I，DAR值约6，在乳腺癌领域已获批用于HER2+ BC二线治疗。
- HORIZON-Breast06（NCT05814354）是一项随机、开放标签、多中心的III期临床研究，旨在比较SHR-A1811与研究者选择的化疗在**HER2低表达（IHC1+或IHC2+/ISH-）**晚期乳腺癌患者中的有效性与安全性。主要终点为BICR评估PFS，分别在未接受过化疗人群以及全人群中进行检验。
- 数据截止时间为2026年3月20日，共551例患者完成随机分组，SHR-A1811组277例，对照组274例，中位随访时间分别为16.5和14.9个月。试验结果显示，**未接受化疗人群SHR-A1811组mPFS为16.6个月，对照组6.8个月，HR=0.25**（95%CI 0.19-0.33，P＜0.001）；全人群SHR-A1811组mPFS为16.4个月，对照组6.8个月，HR=0.27（95%CI 0.21-0.34，P＜0.001）；全人群ORR为75.5%对比41.2%；中位DoR为15.0个月对比6.8个月， SHR-A1811抗肿瘤抑制时间更持久。全部预设亚组均观察到瑞康曲妥珠单抗的PFS获益，其中**HR+亚组mPFS 16.4个月对比6.7个月，HR=0.24**；HR-亚组mPFS 16.5个月对比 6.8个月，HR=0.34。
- 安全性方面，SHR-A1811组中位治疗持续时间13.8个月，长于对照组5.6个月；整体安全性可控，且间质性肺疾病（ILD）整体发生率低，**SHR-A1811组发生ILD 2.5%(7例)，其中≥3级 1.1%(3例)，**未出现新的安全性信号。

SHR-A1811未接受过化疗人群PFS



SHR-A1811全人群PFS



证监会审核：证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210

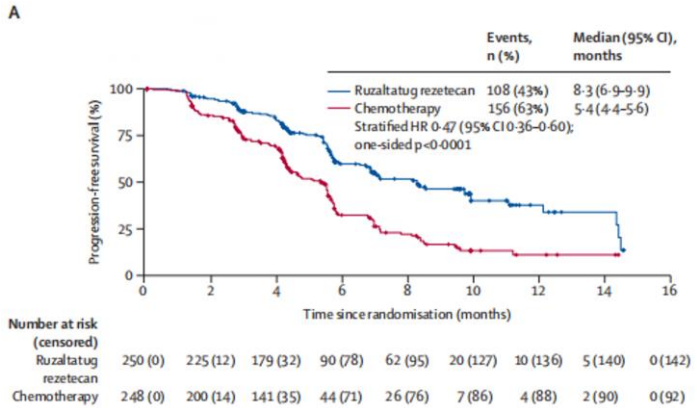
数据来源：恒瑞医药公众号

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

恒瑞医药：SHR-A2009二线治疗EGFRm NSCLC mPFS达8.3个月

- SHR-A2009是一种由全人源抗HER3 IgG1单克隆抗体、可裂解肽连接子和DNA拓扑异构酶I抑制剂载荷组成的HER3 ADC，DAR值为4。既往I期试验显示，SHR-A2009在经治 EGFR突变NSCLC中具有良好抗肿瘤活性和可管理的安全性。
- III期HERON-Lung01研究纳入EGFR 突变（Ex19del/L858R）、经EGFR-TKI进展**（97%的患者既往使用过三代EGFR-TKI，其中78%一线使用）**的晚期非鳞NSCLC患者，按1:1随机接受SHR-A2009（8mg/kg，静脉滴注，Q3W）或含铂化疗（PBC：培美曲塞500mg/m²+卡铂AUC 5或顺铂75mg/m²，Q3W，共4周期，随后培美曲塞维持）。PBC组疾病进展后允许交叉至 SHR-A2009。主要终点为经BICR评估的PFS。
- 截至2026年4月15日，共有498例患者被随机分组，其中SHR-A2009组250例，化疗组248例。试验结果显示，经BICR评估，**SHR-A2009组mPFS为8.3个月，优于化疗组的5.4个月，HR=0.47（95%CI 0.36-0.60，P＜0.001）**。亚组分析显示，在全部预设亚组中（包括按年龄、性别、EGFR突变类型、是否合并脑/肝转移、既往三代EGFR-TKI暴露等分层），经BICR评估的PFS获益趋势一致，SHR-A2009在各亚组均展现优于化疗的PFS获益。OS数据尚不成熟，但结果显示SHR-A2009组优于PBC组（HR=0.70；95%CI，0.43–1.14），尽管有相当一部分患者在疾病进展后从PBC组转入SHR-A2009组（19.4%）。SHR-A2009组的ORR（60.0% vs 34.3%）、DCR（92.8% vs 83.1%）和mDoR（8.5 vs 4.4个月）也均优于PBC组（经BICR评估）。
- 安全性方面，SHR-A2009组3级及以上TRAE发生率为40.7%，化疗组为38.9%，最常见的不良事件包括中性粒细胞计数降低（25.8% vs 19.2%）、白细胞计数降低（11.7% vs 12.1%）和贫血（6.0% vs 10.9%）。**SHR-A2009组有6例患者（2.4%；1-2级5例；3级1例）发生间质性肺病。**SHR-A2009组有1.2%的患者因TRAE而停止用药，PBC 组有1.3%的患者因TRAE而停止用药。

SHR-A2009 BICR评估PFS数据



数据来源：Xu CR, et al. Ruzaltatug rezetecan versus chemotherapy for EGFR-mutated advanced non-small-cell lung cancer progressing after EGFR tyrosine kinase inhibitor therapy (HERON-Lung01): interim analysis of a randomised, open-label, phase 3 trial in China

机构专供，禁外传未经许可不得收录
VX:FCCNN88

恒瑞医药：HRS-4642联合GnP治疗G12D突变PDAC新辅助治疗II期数据积极

- 尽管晚期PDAC的KRAS G12D靶向治疗已有进展，围手术期治疗仍主要依赖吉西他滨联合白蛋白结合型紫杉醇（GnP）等化疗。本文报告KRASG12D抑制剂HRS-4642联合GnP±阿得贝利单抗，用于可切除或交界可切除KRAS G12D突变胰腺癌围手术期治疗的数据。HRS-4642是恒瑞自主研发的一种新型高亲和力、非共价KRAS-G12D抑制剂，采用脂质体纳米颗粒制剂静脉给药，可增强肿瘤蓄积、延长靶点抑制时间，并减少脱靶毒性。
- 此次ESMO更新的开放标签、前瞻性II期试验纳入初治、可切除、KRAS G12D突变胰腺癌患者。患者接受8个每3周一次的围手术期周期：HRS-4642（第1天500mg，第8天1200mg）联合GnP（白蛋白结合型紫杉醇125mg/m²第1、8天；吉西他滨1000mg/m²第1、8天），不含（队列1）或含（队列2）阿得贝利单抗（1200mg，第1天）。采用BOP2设计。主要终点为按RECISTv1.1的ORR及安全性。次要终点包括R0切除率、主要病理缓解（MPR；CAP评分0–1）率、EFS、OS及探索性生物标志物。
- 截至2026年9月3日，每队列各入组30例。基线：中位年龄64岁（范围47–73 vs 39–75）；ECOG均为1；男性70% vs 60%；I/II/III期分别为3%/67%/30% vs 0%/60%/40%。全部接受新辅助治疗且至少有1次治疗后评估。所有患者均发生治疗相关不良事件（TRAE）。≥3级事件发生率：队列1为47%，队列2为53%，最常见为中性粒细胞减少和白细胞减少。无致死性TRAE，亦无因TRAE无法手术者。所有患者均见肿瘤缩小。
- ORR：队列1为63%（19例PR），队列2为87%（26例PR）。手术：队列1共23例、队列2共29例；每队列各1例拒绝手术，队列1另有4例仍在新辅助周期中。已切除患者中，两队列R0切除率均为100%，MPR率均为17%。6个月EFS率：队列1为87%，队列2为96%；生存数据尚不成熟。基线CA19-9高于正常上限者均下降≥50%。
- HRS-4642联合GnP在KRAS G12D突变胰腺癌新辅助治疗中显示出良好前景，ORR高、R0切除率高、MPR结果积极且安全性可管理；加入阿得贝利单抗有进一步增效潜力。

证监会审核：证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210

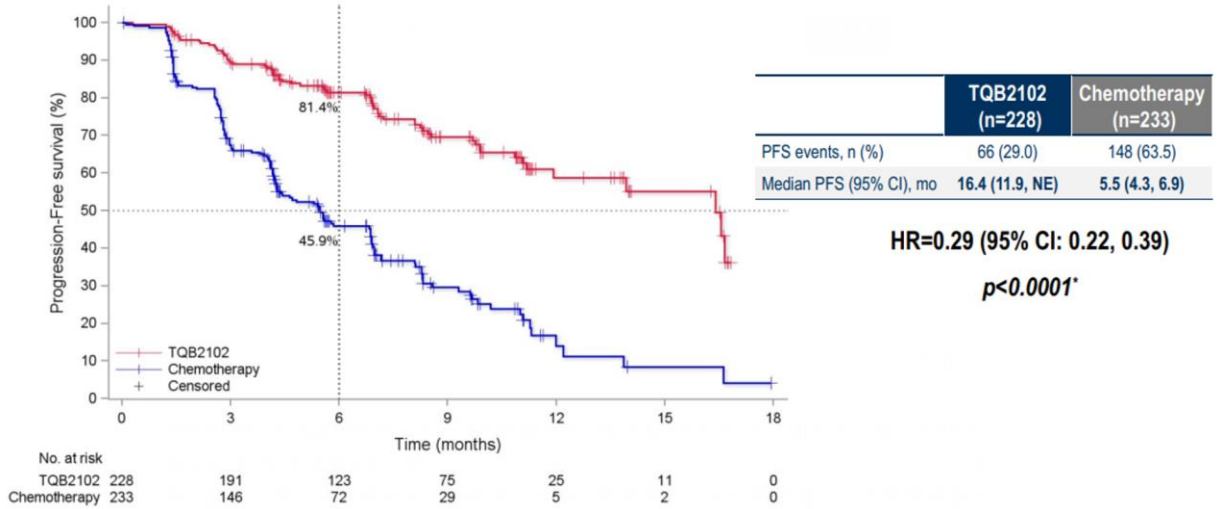
知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

中国生物制药：TQB2102 III期APEX-Breast01研究结果积极

华创研究

- TQB2102是公司自主研发的新一代HER2双表位ADC，能够同时靶向HER2的ECD 2与ECD 4结构域，采用可裂解连接子及拓扑异构酶I抑制剂载荷。
- APEX-Breast01研究是一项多中心、随机、对照的III期临床试验，入组**既往未接受过晚期化疗的HER2低表达复发/转移乳**腺癌患者，包括复发/转移阶段接受过至少1线内分泌治疗后疾病进展的HR阳性患者。研究主要终点为BIRC评估的HR+/HER2低表达人群PFS，关键次要终点为全部HER2低表达人群的PFS。
- 截至2026年5月31日，研究共随机入组543例患者，其中461例为HR阳性患者**（超90%曾接受CDK4/6抑制剂治疗）**，TQB2102组269例，化疗组274例。试验结果显示：在HR+/HER2低表达人群，TQB2102组**mPFS达到16.4个月，化疗组为5.5个月（HR=0.29，95%CI：0.22–0.39；p<0.0001）**；在HER2低表达全人群，TQB2102组mPFS同样达到16.4个月，也显著优于化疗组5.5个月（HR=0.29，95%CI：0.22–0.38；p<0.0001）。在CDK4/6抑制剂经治进展的HR+患者占比较高的研究人群中，TQB2102取得显著的PFS获益，HR为0.29。在HER2低表达全人群中，TQB2102组ORR达到68.8%，高于化疗组31.0%；中位DoR分别为15.0个月和7.1个月。
- 安全性方面，TQB2102组治疗相关ILD发生率为2.2%，3级ILD发生率仅为1.1%，未出现ILD相关死亡事件。在整体治疗耐受性方面，TQB2102组与化疗组因治疗相关不良事件导致永久停药的比例均为1.5%，总体安全可耐受。

TQB2102 HR+/HER2低表达人群PFS

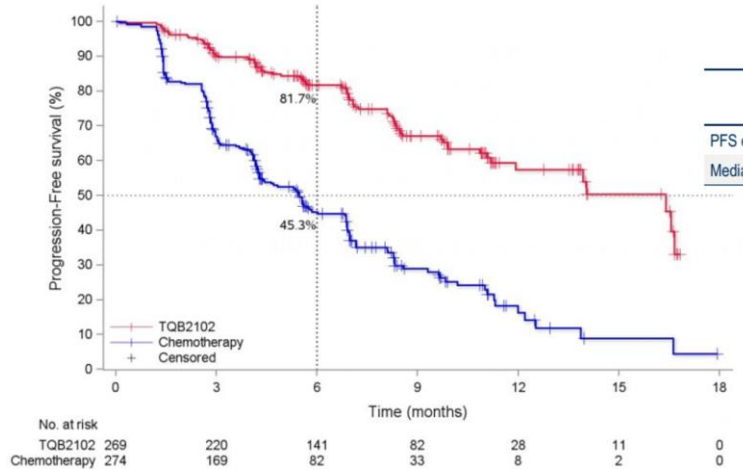


	TQB2102 (n=228)	Chemotherapy (n=233)
PFS events, n (%)	66 (29.0)	148 (63.5)
Median PFS (95% CI), mo	16.4 (11.9, NE)	5.5 (4.3, 6.9)

HR=0.29 (95% CI: 0.22, 0.39)

p<0.0001

TQB2102 HER2低表达全人群PFS



	TQB2102 (n=269)	Chemotherapy (n=274)
PFS events, n (%)	78 (29.0)	174 (63.5)
Median PFS (95% CI), mo	16.4 (11.9, NE)	5.5 (4.3, 6.9)

HR=0.29 (95% CI: 0.22, 0.38)

p<0.0001

数据来源：肿瘤瞭望《ESMO 2026现场直击！全球首款HER2双表位ADC，显著改善HER2低表达乳腺癌PFS》

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

百济神州：泽尼达妥单抗联合替雷利珠单抗与化疗HER2+ GEA一线OS达27个月

- HERIZON-GEA-01（NCT05152147）是由百济神州与Jazz Pharmaceuticals共同开展的一项全球、随机、开放性的III期临床研究，旨在评估和比较在联合化疗的基础上，泽尼达妥单抗（zani）单药或联合替雷利珠单抗（TIS）相比标准治疗（曲妥珠单抗联合化疗，tras + CT）作为晚期或转移性HER2+GEA一线治疗的有效性和安全性，该研究双重主要终点分别为经BICR的PFS和OS。在第一次期中分析（IA1）中，zani联合CT，无论是否联合TIS，均显著延长了PFS；其中，zani + CT + TIS 相较于tras + CT还带来了显著OS获益（HR = 0.72）。这些结果支持上述方案在美国获批用HER2+ mGEA的一线治疗。本文报告预设的第二次OS期中分析（IA2）。
- 截至2026年7月15日，该研究随机入组了914例患者，中位随访时间35.3个月（较IA1延长9.4个月），**zani + CT + TIS较tras + CT持续展现长期生存获益，前者的mOS达27.0个月**，死亡风险率降低35%（HR=0.65; 95% CI: 0.52-0.80），较第一次期中分析的HR值0.72进一步改善。zani + CT较tras + CT治疗有显著的OS改善，两组mOS分别为22.9个月和19.6个月（HR=0.76; 95% CI: 0.62-0.93; P=0.0088）。
- zani + CT + TIS 对比 zani + CT中位OS为27.0 vs 22.9个月，延长约 4 个月（HR=0.81；95% CI: 0.65-1.00）；但在统计效能不足的分析背景下，该差异未达到统计学显著性（P=0.0502）。肿瘤不同PD-L1表达状态均观察到一致的OS改善趋势。在肿瘤PD-L1阴性患者（TAP<1%）中，死亡风险率降低24%（HR=0.76; 95% CI: 0.52-1.10）；在肿瘤PD-L1阳性患者（TAP≥1%）中，死亡风险率降低23%（HR=0.77; 95% CI: 0.58-1.02）。
- 在PFS方面， zani + CT + TIS较tras + CT展现出显著改善，两者的mPFS分别为12.7个月和8.3个月（HR=0.61；95%CI: 0.50-0.76）。zani + CT的mPFS达到12.4个月，较tras + CT的进展风险率降低35%（HR=0.65; 95%CI: 0.50-0.76）。
- 安全性方面，IA2安全性结果总体与第一次期中分析结果以及各药物的已知安全性特征一致，未发现新的安全性信号。腹泻是最常见的3级以上TRAE。大多数腹泻事件发生在治疗早期，应在第一个治疗周期采取强制的抗腹泻预防措施。

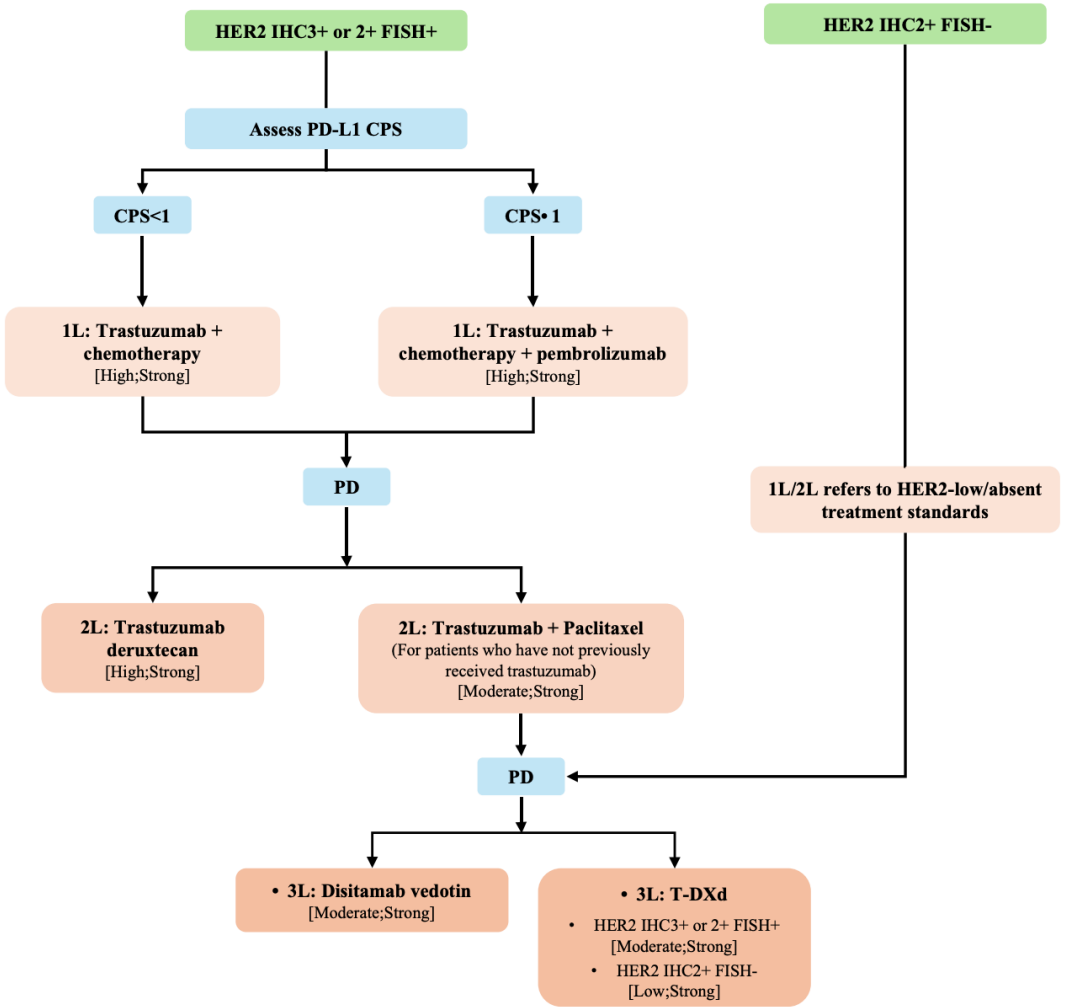
证监会审核，证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

石药/康宁杰瑞：KN026联合化疗二线治疗HER2+ GC/GEJ中位OS达19.6个月

- 安尼妥单抗（KN026）是中国首个上市的国产HER2双抗，基于康宁杰瑞CRIB平台研发，可同时精准结合HER2受体的两个非重叠表位（结构域IV与结构域II），全面阻断下游信号通路，同时增强HER2内吞能力、下调HER2表达，且保留了Fc段介导的ADCC效应。并已于2026年5月通过NMPA优先审评审批程序获批上市。
- KN026-001是一项随机、双盲、对照、多中心III期临床研究，入组经曲妥珠单抗治疗后疾病进展的HER2+ GC/GEJ患者，随机接受KN026联合化疗或安慰剂联合化疗治疗主要终点为经IRC评估的PFS和OS。
- 截至2026年7月15日，试验共入组246例（KN026联合治疗组125例，对照组121例）KN026联合治疗组中位随访时间22.8个月，对照组中位随访时间22.3个月。KN026联合治疗组**mOS为19.6个月，对照组为9.6个月（HR=0.39；95%CI：0.28-0.54；P<0.0001）**。所有预设亚组中均观察到一致的OS获益。IRC评估的mPFS分别为7.1个月和2.7个月（HR=0.35；95%CI：0.26-0.48；P<0.0001），INV评估的PFS结果与IRC评估相似。
- 安全性方面，KN026联用治疗组3级及以上TRAEs发生率为69.4%，对照组为47.9%；最常见的TRAEs为中性粒细胞减少（33.1% vs.24.8%）、白细胞减少（27.4% vs 25.6%）和贫血（24.2% vs 12.4%）。对照组发生5例TRAEs导致的死亡， KN026联合治疗组则未发生。
- 因此，KN026联合化疗显著延长了既往含曲妥珠单抗治疗失败的HER2+GC/GEJ患者OS，中位OS实现翻倍，有望成为HER2+ GC/GEJ二线治疗新标准 **（DESTINY-Gastric04研究T-DXd vs 雷莫西尤单抗+紫杉醇mPFS分别为6.7 vs 5.6个月，HR 0.74；mOS分别为14.7 vs 11.4个月，HR 0.70）**

HER2+ GC现有治疗路径



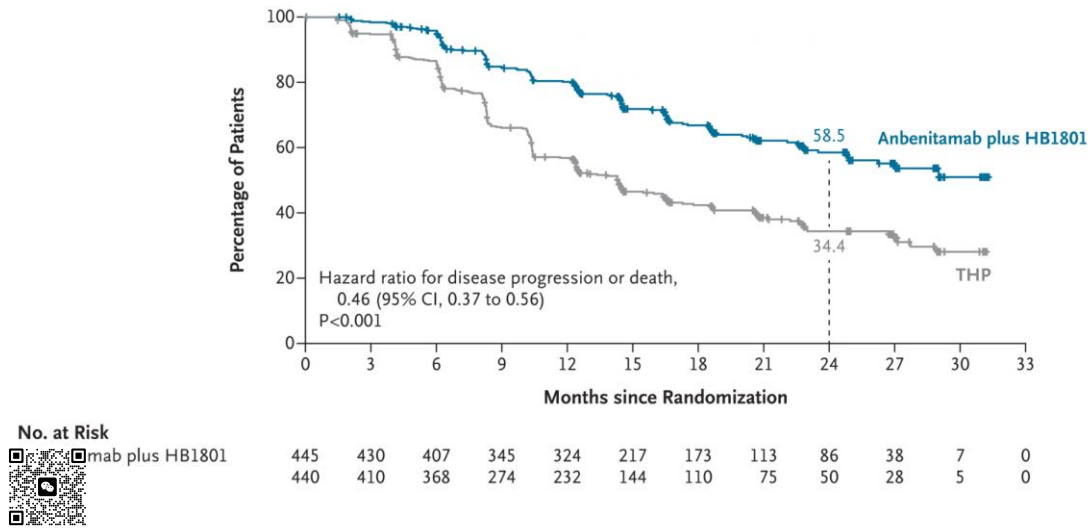
数据来源：Zhang et al. Chinese guidelines for HER2-targeted therapy in gastric and gastroesophageal junction adenocarcinoma (2025 Edition)

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

石药/康宁杰瑞：KN026联合白蛋白多西他赛一线治疗HER2+ BC击败THP

- THP 方案（多西他赛 + 曲妥珠单抗 + 帕妥珠单抗）是 HER2+晚期乳腺癌的一线标准疗法，然而转移性病变仍无法治愈，近半数患者在两年内出现疾病进展。安尼妥单抗（KN026）是一种新型HER2靶向双特异性抗体。
- 2026 ESMO大会报告了KN026联合HB1801（白蛋白结合型多西他赛）对比THP方案在一线治疗中的期中疗效与安全性结果。HEALER研究为一项多中心、随机、开放标签III期试验，纳入HER2+晚期乳腺癌、且晚期阶段未接受过化疗或HER2靶向治疗的患者，随机接受KN026联合HB1801或THP，分层因素为既往辅助/新辅助治疗、激素受体状态及有无内脏转移。主要终点为BIRC评估的PFS。
- 截至2026年4月30日，试验共入组885例（KN026组445例、THP组440例），经BIRC评估，**KN026组mPFS尚未达到，THP组为14.3个月，24个月PFS率分别为58.5% vs 34.4%（HR=0.46；95% CI 0.37–0.56；p<0.0001）**，研究者评估的PFS改善趋势一致（HR=0.52；95%CI 0.43–0.64）。BIRC确认的ORR分别为87.6%与73.4%；mDoR分别为NR与16.6个月。OS数据尚不成熟，但KN026组已见获益趋势。
- 在安全性方面， KN026组3级及以上不良事件发生率为45.9%，THP组为34.4%，最常见的3级及以上不良事件主要为中性粒细胞减少（13.1% vs 8.4%）、白细胞减少（9.7% vs 5.5%），以血液学毒性为主。因TEAE导致治疗终止发生率低（5.2% vs 3.4%），耐受性良好。3级及以上TRAE发生率分别为36.9%和25.3%。心脏毒性方面，左心室功能障碍和射血分数降低的发生率分别为2.9%和8.1%，3级及以上事件分别为0.5%和1.8%，与传统抗HER2靶向治疗的已知安全性特征一致。

BIRC评估PFS数据



证监会审核，证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210

数据来源： Wang et al. Anbenitamab plus HB1801 for HER2-Positive Advanced Breast Cancer

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

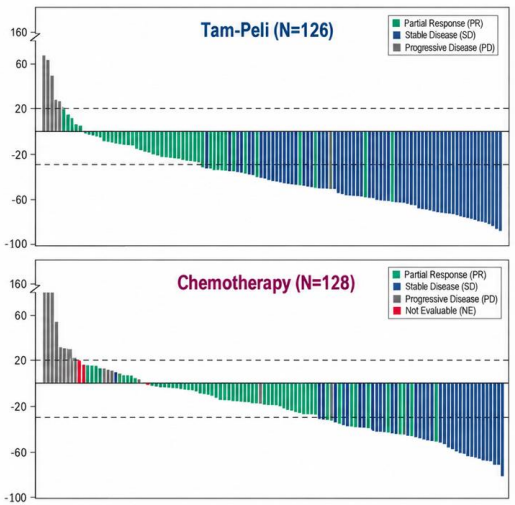
宜联生物/罗氏：B7-H3 ADC治疗R/M NPC的III期研究结果阳性

- 复发/转移性鼻咽癌（R/M NPC）在免疫治疗及多线化疗后仍难以治疗。YL201是依托宜联生物TMALIN平台构建的B7-H3靶向ADC，由人源化抗B7-H3单克隆抗体、可裂解连接子及喜树碱TOP1抑制剂载荷组成，DAR约为8。2026年1月，宜联生物以5.7亿美元首付款及近期里程碑付款将YL201海外权益授予罗氏。
- TAISHAN-301是一项多中心、随机、开放标签III期研究（NCT06629597），旨在评估YL201对比研究者选择的化疗在重度经治的R/M NPC中的有效性和安全性。截至2026年3月17日，研究共随机入组431例R/M NPC患者，按1：1分配至YL201组（2.4mg/kg，D1 Q3W，最大剂量200mg）或研究者选择的化疗组。入组患者既往接受过PD-(L)1抑制剂及至少两线化疗（其中至少一线为含铂方案）。主要终点为BICR评估的ORR和OS，关键次要终点为BICR评估的PFS。
- 根据方案预设，入组的前254例患者将用于本次ORR分析，经IDMC审查，BICR评估的经确认的ORR达到主要终点：**YL201组经确认的ORR显著高于化疗组（50.8% vs 25.8%; OR 2.9, 95%CI: 1.7, 5.0; P＜0.0001）**；两组DCR分别为93.7%和75.8%。亚组分析进一步显示，相较化疗，依康坦博妥塔单抗在各亚组均显示出ORR获益。
- 安全性方面，YL201总体耐受性良好。在全部431例患者中，≥3级TRAEs发生率为49.3%，化疗组为51.7%。YL201的常见不良事件以血液学毒性为主。本研究预设的特别关注不良事件（AESI）包括≥3级输液相关反应和所有级别的间质性肺疾病（ILD）/非感染性肺炎，YL201组未观察到上述AESI。

Tam-Peli demonstrated statistically significant and clinically meaningful ORR improvement over chemotherapy.

BOR per BICR	Tam-Peli (N=126)	Chemotherapy (N=128)
Best overall response (BOR), n (%)		
Complete response (CR)	0	0
Partial response (PR)	64 (50.8)	33 (25.8)
Stable disease (SD) / Non-CR/Non-PD	54 (42.9)	64 (50.0)
Progressive disease (PD)	5 (4.0)	16 (12.5)
Not evaluable (NE) *	3 (2.4)	15 (11.7)
Objective response rate (ORR), % (95% CI) †	**50.8 (41.7, 59.8)**	**25.8 (18.5, 34.3)**
Odds ratio (OR), (95% CI) ‡	2.9 (1.7, 5.0)	
One-side *P* value ‡	<0.0001	
Treatment group difference, % (95% CI) §	24.1 (12.8, 35.4)	
Disease control rate (DCR), % (95% CI) †	93.7 (87.9, 97.2)	75.8 (67.4, 82.9)
Median duration of response (DoR), months (95% CI)	7.9 (4.6, NR)	6.4 (4.9, NR)
Median time to response (TTR), months (range)	1.5 (1.3, 4.9)	1.5 (1.2, 5.5)

* Includes patients defined as not evaluable per RECIST 1.1, or who do not meet the minimum interval requirement for SD, or without post-baseline scans.
† **The ORR and DCR was evaluated in the first 254 randomized patients per protocol.** The 95% CIs are calculated using Clopper-Pearson method.
‡ OR (95% CI) and one-side *P* value is based on the stratified Cochran-Mantel-Haenszel test. The stratification factors are obtained from the IWRS.
§ The rate difference between the treatment groups and associated 95% CI are calculated based on the stratified Miettinen-Nurminen method. The stratification factors are obtained from the IWRS.
BICR, blinded independent central review; CI, confidence interval; IWRS, interactive web response system; NR, not reached.



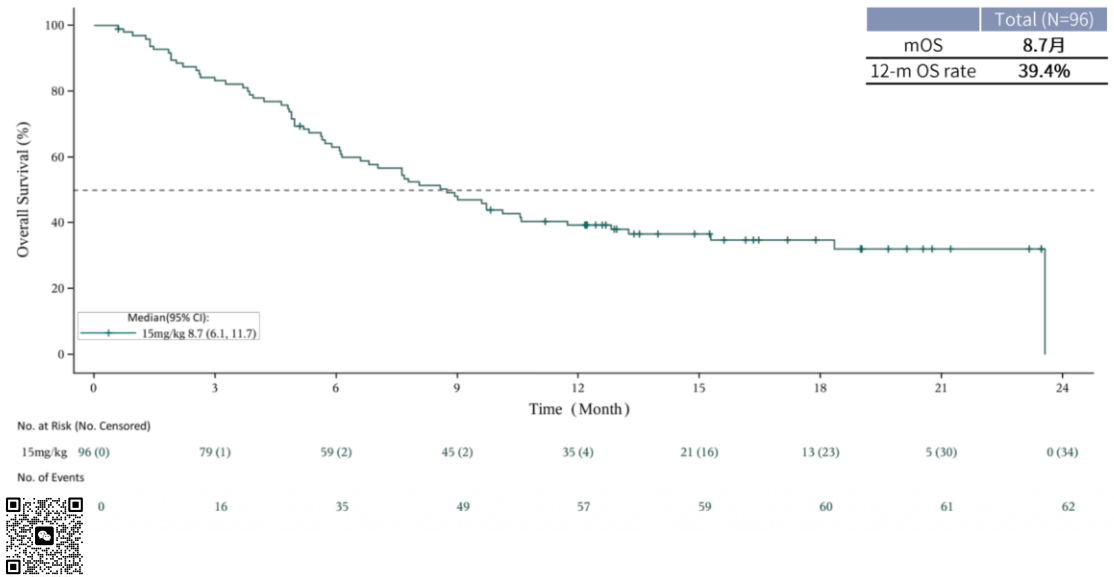
知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

维立志博：LBL-024末线治疗EP-NEC单药mOS达8.7个月

华创研究

- 神经内分泌癌（NEC）是一种高度恶性的免疫冷肿瘤，约占神经内分泌肿瘤的10%-20%，肺、消化道、膀胱等多种器官均可发病。NEC可分为肺NEC和EP-NEC。EP-NEC与小细胞肺癌（SCLC）高侵袭转移特征相似，疾病进展迅速，大多数NEC在诊断时分期较晚或已伴有远处转移，且针对NEC的系统治疗策略有限，疗效欠佳，预后不良。目前，全球范围内尚无药物获得监管批准用于EP-NEC的治疗。晚期EP-NEC的一线治疗主要以含铂化疗为主，ORR约为30%-50%，mOS仅1年左右。一线治疗进展后则无标准治疗方案，二线治疗可考虑采用奥沙利铂为主的FOLFOX方案，ORR约为10%-25%，mOS约为8个月。三线尚无推荐疗法，历史mOS仅3-4个月。
- LBL-024是维立志博首创的PD-L1×4-1BB双特异性抗体，旨在促进肿瘤局部的T细胞活化，同时限制全身性毒性。既往I-IIa期研究显示，LBL-024在晚期EP-NEC中具有临床意义的抗肿瘤活性，为本项关键性IIb期研究提供了依据。
- 截至2026年8月16日，3L+ EP-NEC共计入组96名患者，中位随访时间为16.3个月。12个月OS 率为39.4%，mOS为8.7个月，疗效不依赖于PD -L1表达；cORR为26.0%。mDOR为9.8个月，其中13例（13.5% ）接受治疗超过12个月，7例患者接受治疗超过15个月，4例患者（含3例CR）治疗超过20个月。无肝转移亚组ORR为43.8%(14/32)，mOS 为10.5个月。

LBL-024总体生存KM曲线



LBL-024安全性数据

发生率≥15%的TRAEs		
首选术语，n (%)	任何级别	≥3级
贫血	39 (40.6)	6 (6.3)
AST升高	**31 (32.3)**	**2 (2.1)**
ALT升高	**30 (31.3)**	**0**
白细胞计数降低	20 (20.8)	4 (4.2)
γ-谷氨酰转移酶升高	**18 (18.8)**	**4 (4.2)**
血小板计数降低	18 (18.8)	3 (3.1)
蛋白尿	18 (18.8)	0
血肌酸磷酸激酶升高	17 (17.7)	2 (2.1)

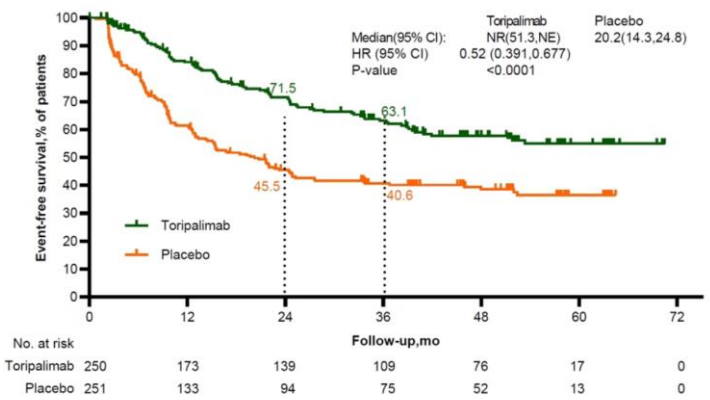
知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

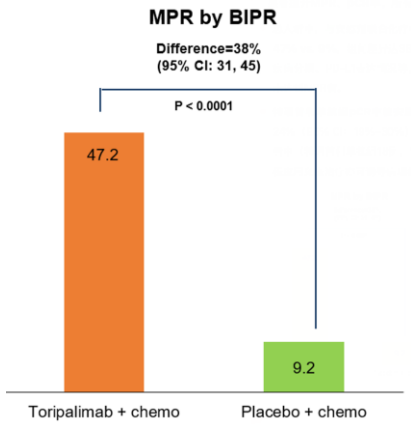
君实生物：特瑞普利单抗NSCLC围手术期治疗III期临床EFS阳性

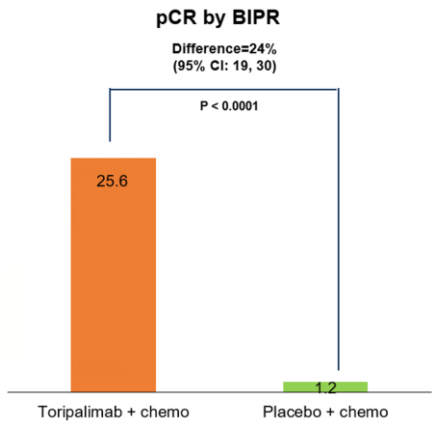
华创研究

- NEOTORCH研究首创“3周期术前免疫化疗+1周期术后辅助免疫化疗+13周期免疫单药维持”的“3+1+13”全程围手术期治疗模式，旨在评估该治疗模式对比安慰剂联合化疗用于II/III期可切除NSCLC患者围手术期治疗的疗效和安全性。2026年7月，基于此次公布的II-III期全人群最终分析结果，NMPA已正式受理了特瑞普利单抗NSCLC围手术期适应症由可切除IIIA-IIIB期扩展至可切除II-III期NSCLC患者的补充申请。
- NEOTORCH（NCT04158440）是一项在国内55家中心开展的随机、双盲、安慰剂对照的III期临床试验。研究共入组501例II-III期NSCLC患者，以1:1的比例随机接受特瑞普利单抗（240mg，Q3W）或安慰剂联合化疗（鳞癌：紫杉类+铂类，非鳞癌：培美曲塞+铂类）术前3周期及术后1周期围手术治疗，随后接受特瑞普利单抗（240mg，Q3W）或安慰剂巩固治疗13周期（即“3+1+13”治疗模式）。主要终点为III期及II-III期患者的INV-EFS和BIPR-MPR。次要终点包括OS、IRC评估的EFS、pCR、DFS和安全性等。
- 总人群中，与安慰剂联合化疗相比，特瑞普利单抗联合化疗显著延长EFS，中位INV-EFS分别为NR vs 20.2个月（HR=0.52，95%CI：0.39-0.68，分层P<0.0001）。两组2年和3年EFS率分别为72% vs 46%、63% vs 41%。III期患者中，中位随访52.9个月，特瑞普利单抗组和安慰剂组中位INV-EFS分别为NR vs 15.4个月（HR=0.47；95%CI：0.35-0.64；P<0.0001），显示出与期中分析（HR=0.40）一致的EFS获益。总人群中，与安慰剂联合化疗相比，特瑞普利单抗联合化疗显著提升MPR率，两组BIPR-MPR分别为47% vs 9%，组间差异达38%。亚组分析显示，所有亚组MPR率均有改善。
- 整体安全性可管理，两组TEAE发生率相似，未发现新的安全信号。特瑞普利单抗组和安慰剂组的≥3级TEAE发生率分别为68% vs 57%，最常见的TEAE（任一组发生率≥30%）包括贫血、中性粒细胞减少、白细胞减少等，大多为1-2级。

NEOTORCH研究疗效数据







知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

荣昌生物：维迪西妥单抗治疗EMPD单药ORR达88%

- 乳腺外佩吉特病（EMPD）是一种罕见的皮肤恶性肿瘤。亚洲人群的估计年发病率约为0.28/10万人年。对于不可切除或转移性EMPD，目前尚缺乏统一的标准系统治疗方案，多西他赛是常用化疗选择之一。既往小样本回顾性研究报道，多西他赛单药的ORR约为35.7%–58.3%，但3–4级骨髓抑制发生率为66.7%。更严峻的是，远处转移患者预后较差，历史研究报道5年生存率约为7%。临床亟需高效、低毒的精准治疗方案。在此背景下，HER2成为了关键的破局靶点。中山大学肿瘤防治中心的一项研究发现，90.2%的EMPD存在HER2表达，其中71.6%为高表达（IHC 2+/3+），且HER2高表达是独立的不良预后因素。
- Formula-10是一项前瞻性、开放标签、单臂II期临床试验（ChiCTR2500100703）。符合条件的成年患者须患有不可切除的局部晚期或转移性EMPD，且经免疫组织化学检查确认HER2表达为IHC 2+或3+。患者接受DV 2.0mg/kg、每两周一次治疗，直至疾病进展或出现不可耐受的毒性。主要研究终点为治疗3个月时的ORR。次要终点包括DCR、PFS、DoR、OS、安全性和生活质量。
- 截至2026年8月15日，共入组27例患者，其中HER2 IHC 2+和3+患者分别占77.8%和22.2%。18例患者（66.7%）存在远处转移，5例患者（18.5%）既往接受过化疗。中位随访时间为15.03个月。在25例疗效可评估患者中，研究者评估的cORR为88.0%，DCR为100%，包括4例CR、18例PR和3例SD。中位PFS为14.23个月（95% CI：9.87–20.37个月），中位DoR为10.90个月，OS数据尚未成熟。
- 在展现强效抗肿瘤活性的同时，维迪西妥单抗体现了ADC药物“高效低毒”的精准递送优势。常见TRAE包括疲乏（88.9%）、感觉异常（81.5%）、食欲减退（55.6%）和脱发（55.6%），3级及以上TRAE发生率为29.6%，其中包括感觉异常（14.8%）和疲乏（11.1%），整体安全性可控。与既往化疗超过60%的严重不良事件发生率相比，患者耐受性得到了显著改善。

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

微芯生物：西达本胺联合纳武利尤单抗III期临床降低27%疾病进展风险

- 在免疫治疗和靶向治疗的推动下，晚期黑色素瘤患者的预后已得到显著改善。在一项针对PD-(L)1抑制剂初治晚期黑色素瘤患者的1b/2期研究中，口服选择性组蛋白去乙酰化酶（HDAC）抑制剂HBI-8000联合纳武利尤单抗（NIVO）达到了66%的ORR。
- HBI-8000-303是一项全球性、随机、双盲、安慰剂对照的III期研究，旨在评估NIVO联合HBI-8000在未经PD-(L)1抑制剂治疗的不可切除或转移性黑色素瘤患者中的疗效。患者基线特征包括晚期、非葡萄膜黑色素瘤、具有可测量病灶、ECOG体能状态评分为0-1且器官功能良好。这些患者被随机分配接受口服HBI-8000 30 mg或安慰剂治疗（每周两次），并联合NIVO 480 mg给药（每4周静脉注射一次），按肿瘤PD-L1表达和血清LDH水平进行分层。主要终点是由BICR评估的PFS。次要终点包括ORR、OS和安全性。
- 在2021年7月至2024年4月期间，共有404例患者被随机分配至HBI-8000+NIVO组（n=203）或安慰剂+NIVO组（n=201）。患者特征基线平衡；33.7%（136/404）的患者伴有LDH升高。中位随访时间为37个月。
- HBI-8000+NIVO组的中位PFS为11.7个月（95% CI: 7.3, 21.1），显著高于安慰剂+NIVO组的7.4个月（95% CI: 4.5, 10.1）；风险比为0.73（96% CI: 0.56 – 0.95，P=0.0141）。HBI-8000+NIVO组的确认ORR为41.4%（95% CI: 34.5, 48.5），安慰剂+NIVO组为32.3%（95% CI: 25.9, 39.3）。
- 安全性方面，HBI-8000和安慰剂组中，≥3级TRAEs的发生率分别为55%和18%；因任何级别的TRAE而停止治疗的比例分别为14%和5%。HBI-8000+NIVO组最常见（>20%）的TRAEs为腹泻、恶心、疲劳、血小板减少、乏力和中性粒细胞减少。
- 因此，在未经PD-(L)1抑制剂治疗的晚期黑色素瘤患者中，与单用NIVO相比，HBI-8000联合NIVO在PFS方面取得了显著改善。其毒性特征与HDAC抑制剂类效应一致，且通常可逆。

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

风险提示

- 临床进度不达预期
- 竞争格局变动
- 销售不及预期

证监会审核...券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

免责声明

分析师声明

每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此作以下声明：

分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断；分析师对任何其他券商发布的所有可能存在雷同的研究报告不负有任何直接或者间接的可能责任。

免责声明

本报告仅供华创证券有限责任公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司在知晓范围内履行披露义务。

报告中的内容和意见仅供参考，并不构成本公司对具体证券买卖的出价或询价。本报告所载信息不构成对所涉及证券的个人投资建议，也未考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的预期收入可能会波动。

本报告版权仅为本公司所有，本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用本报告的任何部分。如征得本公司许可进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华创证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

证券市场是一个风险无时不在的市场，请您务必对盈亏风险有清醒的认识，认真考虑是否进行证券交易。市场有风险，投资需谨慎。

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88